รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี

ผู้มาประชุม

๑. นายนพชัย	ประสงค์สุธน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ประธาน
๒. นางสาวสุริวิภา	พงษพัง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๓. นางศิรินทิพย์	โกนสันเทียะ	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๔. นายวิเชียร	พลอยนิล	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์	กรรมการ
๕. นางสาวสุภาพร	มาลีวรรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	กรรมการ
๖. นางแกมกาญจน์	พรหมบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๗. นางสาวนิภา	กัณหา	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	กรรมการ
๘. นายสันติภาพ	เยี่ยมไธสง	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	กรรมการ
๙. นางสาวรัตนมุขย์	วิโรจน์	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๑๐. นายปัฐวี	วังคีรี	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	กรรมการ
๑๑. นายศิว์วิศว์	ศรีมรรควัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	กรรมการ
๑๒. นางสาวปธิตา	แว่นไธสง	เจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอิสระ	เข็มพุดซา	แพทย์แผนไทย แทน หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางประไพพิมพ์	จุลเศรษฐี	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	ลากิจ
๒. นายอภิวิชญ์	จรัสสุทธิอิศร	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	ติดราชการ
๓. น.ส.อริณสราลักษณ์ พินิจไกร	ธัมมะปัตโต	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ติดราชการ
๔. นางสาวปวิตรา	สีบท	นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์	ติดราชการ
๕. นางสาวปุณณดา	ผลาลทิพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ประสานคุณภาพ	ติดราชการ
๖. นายนพรัตน์	ผลนา	พนักงานขับรถยนต์ ตัวแทนลูกจ้าง	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งจากประธาน และ เรื่องแจ้งจากหน่วยงาน

๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน

ประธาน : ๑.๑.๑ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ๑+๑๑ Agenda Korat

(๑) การปกป้องเชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการตามพระราชดำริ

(๒) เตรียมรับผลกระทบจากสงครามอิสราเอล - อิหร่าน

(๓) ผลงาน ITA

(๔) การบริหารงบประมาณ

(๕) การบริการประชาชน ได้รับความสะดวกในการรับบริการ โดยมีนวัตกรรมในการลดขั้นตอนในการทำงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๒ IQ มากกว่าร้อยละ ๓ โดยมีนโยบาย ๒+๒+๒+๒ (กินไข่ ๒ ฟอง + กินนม ๒ กล่อง + เล่น ๒ ชั่วโมง + นอนก่อน ๒ ทุ่ม) เพื่อเพิ่ม IQ ในเด็ก

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๓ โครงการห่างไกล NCD อำเภอเมืองยาง กลุ่มเป้าหมาย ๕๒๐ คน โดยกลุ่มเป้าหมาย ๕๒ คน ให้ควบคุมได้อย่างน้อย ๑ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๔ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเมืองยาง เป็นพื้นที่สีเหลือง สำหรับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี มีนโยบาย "ไม่ให้อาหารกับสุนัขจรจัด" บุคคลที่ให้อาหารกับสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีเจ้าของ กรณีที่มีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วโดนสุนัขกัด และผู้มารับบริการร้องเรียน ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ โดยจะสืบหาบุคคลที่ให้อาหารแก่สุนัขตัวที่กัดมารับผิดชอบ

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๑.๑.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง ของ CUP เมืองยาง

ในการนำเสนอรับการเยี่ยมเสริมพลังขอนำเสนอวิสัยทัศน์, พันธกิจ และเข็มมุ่ง ของโรงพยาบาลแทนของ CUP เนื่องจากทิศทางการนำของ CUP ยังไม่มีการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ CUP ร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๖ เรื่องแจ้งจากที่ประชุม กวป.

(๑) การดำเนินงานแม่และเด็ก จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ข้อมูลจากรายงาน HDC ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) ขอชื่นชมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมที่สามารถดำเนินงาน KPI ของจังหวัดผ่านทุกข้อ

มติที่ประชุม รับทราบ

(๒) เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ CFO จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

(๒.๑) เงินรายรับ IP โอนตรงเข้าโรงพยาบาลลดลง โดย สปสช.ยืนยันอัตราจ่ายผู้ป่วยในปี ๒๕๖๙ อยู่ที่ ๘,๓๕๐ บาท/ ๑ AdjustRW โดยแบ่งเป็น

เงินเดือน : ๔,๘๔๔.๘๖ บาท

โรงพยาบาล : ๓,๕๐๕.๑๔ บาท

<u>แนวทางการเพิ่มรายได้</u> : - จัดเก็บรายได้ PP OP ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

- IP สรุปชาร์ทผู้ป่วยในตามเวลาที่กำหนด

(๒.๒) ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ Home ward ยกเลิกการจ่ายโรค HT DM สำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลเน้นการ Admit จำนวน ๓ กลุ่มโรค คือ

- โรคแผลกดทับ
- ความผิดปกติทางจิต และพฤติกรรมที่เกิดจากสารออกฤทธิ์ต่อจิตประเภท
- ผู้ป่วยระยะกำลังเสียชีวิตที่บ้าน

(๒.๓) การเพิ่มรายได้ในกลุ่ม OP PP คือ

- HIV - Palliative care - IMC
- Home ward - ANC/หลังคลอด - CA Anywhere
- HbA1C - คัดกรองต่างๆ - แพทย์แผนไทย – PP FC

โดยให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

(๓) รายงานความก้าวหน้าหมวดสินทรัพย์ถาวร (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

- หน่วยบริการที่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๗
- หน่วยบริการที่สามารถดำเนินการได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ๒๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๓ (รพช.๑๕ แห่ง, รพ.สต. ๑๖๕ แห่ง และ สสอ. ๓๒ แห่ง) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี อยู่ในกลุ่มนี้
- รายงานความก้าวหน้าหมวดสินทรัพย์ถาวรกับโรงพยาบาลชุมชน

- มีข้อมูลครบถ้วน ๑๔ แห่ง (มีข้อมูลอยู่ในทะเบียนสินทรัพย์, มีเอกสารหลักฐานประกอบสินทรัพย์อยู่จริงครบถ้วน)

- ข้อมูลไม่ครบถ้วน ๑๖ แห่ง (ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบกับสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง, เอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน)

- โดยจังหวัดกำหนดลงติดตาม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

(๔) ข้อมูล CASE MIXED INDEX (CMI) และอัตราครองเตียงของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

- CASE MIXED INDEX (CMI)
  - ผ่านเกณฑ์ ๓๑ แห่ง คิดเป็น ๙๑.๑๘%
  - ไม่ผ่านเกณฑ์ ๓ แห่ง คิดเป็น ๘.๘๒% ((๑) รพ.ครบุรี ๐.๗๖, (๒) รพ.ลำทะเมนชัย ๐.๕๙, (๓) รพ.มกุฎคีรีวัน (๐.๕๓)
- อัตราครองเตียง ไม่น้อยกว่า ๘๐%
  - อัตราครองเตียง ≥ ๘๐% จำนวน ๑๘ แห่ง คิดเป็น ๕๒.๙๔%
  - อัตราครองเตียง ≤ ๘๐% จำนวน ๑๖ แห่ง คิดเป็น ๔๗.๐๖%
  - อัตราครองเพียงต่ำสุด โรงพยาบาลขามสะแกแสง ๕๑.๘๑% รองลงมาโรงพยาบาลสูงเนิน ๕๓.๔๐% และโรงพยาบาลเทพารักษ์ ๕๔.๙๙%
  - อัตราครองเตียงสูงสุด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ๒๖๐.๗๖% รองลงมาโรงพยาบาลบัวลาย ๑๓๔.๕๕% และโรงพยาบาลโนนแดง ๑๑๗.๕๙%

มติที่ประชุม รับทราบ

(๕) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า**ในคน** ผู้เสียชีวิต ๒ ราย (อำเภอประทาย)
- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า**ในสัตว์** พบเชื้อ สะสม ๒๒ ตัว

มติที่ประชุม รับทราบ

(๖) เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วย พอ.สว. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ อำเภอห้วยแถลง
- การลดระยะเวลารอคอยที่ OPD
- การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ Telemedicine
  - โรงพยาบาลขึ้นทะเบียนครบแล้วจำนวน ๓๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
  - รพ.สต. ขึ้นทะเบียน รวม ๘ อำเภอ ๓๓ แห่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๗ กำหนดการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๙ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ อำเภอเมืองยางขอให้โรงพยาบาลสนับสนุนโต๊ะจีน ๑ โต๊ะ และงบสนับสนุนเครื่องบวงสรวง ๗๐๐ บาท (ขนมจีน/น้ำยา)

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายคุณปธิตาดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ๒,๗๐๐ บาท นำส่งให้กับเสมียนตราอำเภอเมืองยาง

๑.๑.๘ หมวดอัตราค่าบริการในระบบ HOSxp ๑๖ หมวด ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง Update ให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์นัดทีมที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

๑.๑.๙ กำหนดการเยี่ยมเสริมพลังวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ขอเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาติดภาระกิจ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ กลุ่มงานการพยาบาล

คุณศิรินทิพย์ : ๑.๒.๑ นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

ตัวชี้วัด ๒ : ระยะเวลาการรับบริการที่ OPD ลดลง ร้อยละ ๒๐ จาก Baseline

นิยาม : ระยะเวลาการรับบริการที่ OPD ลดลง หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง รพ.และเปิดบัตร จนถึง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยรับยาหรือกลับบ้าน (กรณีไม่มีรับยา) รวดเร็ว ไม่รอคอยนาน ได้รับบริการครบ จบในครั้งเดียว

ข้อมูลระยะเวลรอคอยที่ OPD รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี

รอคัดกรอง (นาที)	คัดกรอง (นาที)	รอพบแพทย์ (นาที)	พบแพทย์ (นาที)	รับยา (นาที)	เวลารวมเฉลี่ย (นาที)
๒๘.๓	NA	๕๖.๓	NA	๒๐.๒	๑๐๔.๗

<u>เป้าหมาย</u> : ระยะเวลาการรับบริการที่ OPD ลดลง ร้อยละ ๒๐ จาก Baseline = ๘๓.๙ นาที*

- แผนพัฒนาเพื่อลดการรอคอย OPD ปี ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ ผลการบริหารคงคลัง (เวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์) ปี ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) ปัญหา/สาเหตุที่ทำให้ระยะเวลาคงคลังฯเกิน ๖๐ วัน

(๑) เข็ม dispos คงค้างจาก COVID-19

(๒) สินค้าบางรายการจำเป็นต้องสั่งในจำนวน/ราคาที่สามารถเปิดบิลได้

(๓) สินค้าบางรายการราคาแพง จำนวนสินค้าน้อย?

(๔) รพ.ติด black list * บริษัทไม่ส่งสินค้า >แก้ไขเบื้องต้นโดยยืมสินค้าจากบริษัทมาใช้ก่อน เมื่อโรงพยาบาลจ่ายหนี้ทางบริษัทจะให้บิลมารับเข้าคลังและจ่ายออกในเดือนต่อไปได้จึงทำให้ยอดเพิ่มขึ้นใน เดือนนั้นๆ

(๕) บริษัทโอเร็กซ์ไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ รพ.สั่งซื้อได้ทุกเดือน เนื่องจากไม่มีสินค้า

(๖) บางรายการหน่วยงานต้องการใช้ เมื่อสั่งซื้อมาใช้แค่เดือนที่ซื้อ ไม่มีการเบิกอีก ทำให้ค้าง Stock

(๗) ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น เช่นถุงมือ ปี ๒๕๖๘ ราคา ๖๘.๗๐ บาท/กล่อง > ปี ๒๕๖๙ ราคา ๗๒.๗๕ บาท/กล่อง เป็นต้น

(๘) มีการสั่งซื้อสินค้า Sterile แบบ Single use เพิ่มขึ้น

(๙) จำนวนผู้ป่วย/ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น จากการขยายบริการต่างๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ ผลการดำเนินการตามแผนสาธารณสุข CUP เมืองยาง ปี ๒๕๖๙

- มีจำนวนทั้งหมด ๑๐ โครงการ
- ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐
- จำนวนงบประมาณทั้งหมด ๔๔๓,๔๙๒ บาท
- งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด ๒๒๑,๔๙๒ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔

ปรับแผนกลางปี ตัดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยวิธีส่องกล้อง งบประมาณ ๑๔๐,๔๐๐ บาท ออก เนื่องจากจังหวัดปรับรูปแบบบริการเป็นแบบเชิงรับ ให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ส่ง Case ที่ผล Fit test บวกไปรับบริการส่องกล้องที่โรงพยาบาลประทาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๔ การทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ปี ๒๕๖๙

สรุปผลสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ของกลุ่มงานการพยาบาล แยกตามประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือ ปี ๒๕๖๙

- จำนวนวเครื่องมือที่สอบเทียบทั้งหมด ๑๑๙ รายการ
- พร้อมใช้งาน (Pass Pass) จำนวน ๘๒ รายการ คิดเป็น ๖๘.๙%
- ชำรุด/เสื่อมสภาพ (Pass Pass) จำนวน ๒๑ รายการ คิดเป็น ๑๗.๖%
- สอบเทียบไม่ได้ (Fail) จำนวน ๙ รายการ คิดเป็น ๗.๖%
- สอบเทียบไม่ผ่าน (ค่าต่ำ/ค่าสูงกว่ามาตรฐาน) (Pass Fail) จำนวน ๗ รายการ คิดเป็น ๕.๙%

ขอทราบแนวทางการดำเนินการตามผลการสอบเทียบว่าหน่วยงานต้องทำอย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมาย งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำแนวทาง

๑.๒.๕ ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานการพยาบาล เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	วันที่	กิจกรรม
๑.	๕,๑๙,๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙	คัดกรองภาวะทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วย DM (ต.กระเบื้องนอก, ต.ละหานปลาวค้าว, ต.เมืองยาง)
๒.	๑๙,๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลและชุมชน : มาตรการสำคัญในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลและชุมชน
๓	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙	ประชุม NSO board
๔	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙	ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอเมืองยาง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานพิธีบวงสรวงและฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) โดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี อยู่ฝ่ายรักษาพยาบาล

ลำดับที่	เรื่อง		กิจกรรม
๑.	<u>กำหนดการ</u>	ภาคเช้า	พิธีสงฆ์, พิธีวางพวงมาลา, พิธีเปลี่ยนผ้าสไบ, พิธีพราหมณ์
		ภาคค่ำ	การรำบวงสรวงท้าวสุรนารี
๒.	<u>การแต่งกาย</u>	<u>ภาคเช้า</u>	๑. ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ไม่สวมหมวก</u> ๒. กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน <u>แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ไม่สวมหมวก</u> ๓. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน <u>แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีไว้ทุกข์ ไม่สวมหมวก</u> ๔. ประชาชนทั่วไป <u>แต่งกายชุดผ้าไทยสีสุภาพ</u> ๕. นักเรียน นักศึกษา <u>แต่งเครื่องแบบของสถาบัน</u>

ลำดับที่	เรื่อง		กิจกรรม
		<u>ภาคบ่าย</u>	๑. ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**<u>แต่งกายชุดผ้าไทยสีสุภาพ</u>** ๒. กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน **<u>แต่งกายชุดผ้าไทยสีสุภาพ</u>** ๓. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน **<u>แต่งกายชุดผ้าไทยสีสุภาพ</u>** ๔. ประชาชนทั่วไป **<u>แต่งกายชุดผ้าไทยสีสุภาพ</u>** ๕. นักเรียน นักศึกษา **<u>แต่งกายชุดผ้าไทยสีสุภาพ</u>**

มติที่ประชุม รับทราบ

คุณสุภาพร : การแข่งขันกีฬาเปตองคู่ผสม “เปตองเมืองยางเกมส์” งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอเมืองยาง ๒๕๖๙ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๒ ทีม ประกอบด้วย

ทีม ๑	ทีม ๒
๑. นายมานพ พร้าวไธสง	๑. นายนภนต์ จิรวิทยากุล
๒. นายเอกชัย ชมโนนลาว	๒. นายสุรพงค์ จงเพียร
๓. นางสาวปวิตรา สีบท	๓. นายสราวุฒิ คำพิมาย
๔. นางสาวปธิตา แว่นไธสง	๔. นางสมจิตต์ เดี่ยวไธสง
๕. นางสาวอริณสราลักษณ์ พินิจไกร ธัมมะปัตโต	๕. นางสาวธัญญาภรณ์ พชสิทธิ์

กำหนดการแข่งขันจะแข่งทุกวันพุธของสัปดาห์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) ดังนั้นจึงขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง

มติที่ประชุม รับทราบและอนุญาต

คุณปธิตา : ด้วยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมการรำบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอเมืองยาง ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๓ คน
- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน ๒ คน
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๔ คน
- กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จำนวน ๒ คน
- งานหน่วยจ่ายกลาง จำนวน ๒ คน
- กลุ่มงานการแพทย์ จำนวน ๑ คน

และในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นการซ้อมใหญ่ ดังนั้นจึงขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ในกลุ่มงานดังกล่าวเข้าร่วมการซ้อมใหญ่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง

มติที่ประชุม รับทราบและอนุญาต

๑.๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

คุณสุริวิภา : ๑.๓.๑ ผลการดำเนินงานทางการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ชม VDO วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินโรงพยาบาล (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓.๒ สรุปยอดเงินบริจาค (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

- เงินบริจาคแบบระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๔๓,๒๑๗.๕๖ บาท
- เงินบริจาคแบบไม่ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๙๓,๗๖๖.๔๖ บาท

- รวมเป็นเงินทั้งหมด ๑๓๖,๙๘๔.๐๒ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓.๓ แบบสำรวจการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาล (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบและกรณีที่เจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่มีให้สามารถส่งคำตอบได้เลย โดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลข้อถัดไป

ประธาน : ๑. โครงการเรี่ยไรดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

คุณสุริวิภา : อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การจัดทำผ้าสามัคคีของโรงพยาบาล ซึ่งได้ปรึกษากับทางเจ้าคณะอำเภอเมืองยางแล้ว Plan จัดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สถานที่จัดทำผ้าป่าวัดนางออ ดังนั้นขอให้นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

คุณวิเชียร ๑.๔.๑ ผลการดำเนินงานการมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแยกตามสิทธิการรักษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)

- ข้อมูลผู้มารับบริการเวรดึก เวลา ๐๐.๐๐ - ๐๕.๕๙ น. (ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) แยกประเภทคนไข้ปกติ และ คนไข้รถนั่ง/รถนอน

ประเภท	เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	เดือนมกราคม ๒๕๖๙	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
คนไข้ปกติ	๔๖ คน	๕๑ คน	๖๘ คน
คนไข้รถนั่ง/รถนอน	๒ คน	๕ คน	๕ คน

กรณีที่จะให้ห้องบัตรขึ้นปฏิบัติหน้าที่เวรดึก คิดเป็น ๓๖๐ บาท X ๓๑ วัน = ๑๑,๑๖๐ บาท

คุณศิรินทิพย์ : เสนอให้ห้องบัตรขึ้นปฏิบัติหน้าที่เวรดึกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เนื่องจากภาระงานเพิ่ม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ห้องบัตรขึ้นปฏิบัติหน้าที่เวรดึกช่วงเทศกาล (ปีใหม่/สงกรานต์) โดยให้เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๖๙ (เทศกาลสงกรานต์)

๑.๔.๒ คู่มือประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) การประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ รอบ

<u>ประเมินรอบที่ ๑/๒๕๖๙</u>

- **ประเมินเชิงปริมาณเท่านั้น*** ดูข้อมูลผ่าน HDC / ๔๓ แฟ้ม /อื่นๆ แล้วแต่ KPI (เชิงคุณภาพ : กลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด)
- ประเมิน ทั้ง ๑) รพ. ๒) สสอ. ๓) รพ.สต. (*จับฉลากตัวแทน รพ.สต. ในสังกัด สธ.)
- ใช้ผลงาน ๖ เดือน : ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
- กลุ่มงานส่งคะแนนประเมินฯ ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙
- ไม่มีอุทธรณ์

<u>ประเมินรอบที่ ๒/๒๕๖๙</u>

- **ประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ** ดูข้อมูลผ่าน HDC / 43 แฟ้ม /อื่นๆแล้วแต่KPI (เชิงคุณภาพ : กลุ่มงานเจ้าของตัวชี้วัดรับผิดชอบ)
- ประเมิน ทั้ง ๑) รพ. ๒) สสอ. ๓) รพ.สต. (*รพ.สต.ในสังกัด สธ.)
- ใช้ผลงาน ๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
- กลุ่มงานส่งคะแนนประเมินฯ ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายใน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙
- การประเมินครั้งที่ ๒ เปิดโอกาสให้อำเภอตรวจสอบและอุทธรณ์คะแนนได้ภายใน ๑ สัปดาห์

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔.๓ แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว รอเงินโอนจาก สปสช.

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔.๔ แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ปี ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) จากการตรวจสอบพบว่ามีรายการที่ซ้ำกับงบค่าเสื่อม และ ของ รพ.สต.ที่ไม่ได้จัดซื้อในงบลงทุนของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงขออนุมัติตัดออกจากรายการ สำหรับรายการที่ ๒๒ ขอปรับแผนกลางปี

คุณศิวศ์วิศว์ : สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานตามคุณลักษณะของกระทรวง ICT จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากรายการที่แต่ละกลุ่มงานขออนุมัติ พบว่า จอคอมพิวเตอร์มีขนาดน้อยกว่าที่กระทรวง ICT กำหนด ดังนั้นจึงขอปรับขนาดของจอคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเท่ากันทั้งหมด โดยราคาไม่เกินแผนที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ มอบงาน IT กำหนด, Spec คอมพิวเตอร์+ อุปกรณ์ เพื่อเป็น Spec กลางให้หน่วยงานไว้ประกอบการทำ TOR

๑.๔.๕ แผนสุขภาพด้านสาธารณสุข CUP เมืองยาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

- โครงการจำนวนทั้งหมด	จำนวน ๔๙ โครงการ
- โครงการที่เสนอแล้ว	จำนวน ๑๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๙	
- เงินบำรุงโรงพยาบาล	จำนวน ๕๒๑,๐๐๐ บาท
- กองทุน LTC	จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- กองทุนโรคเรื้อรัง	จำนวน ๒๓๘,๙๙๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด	จำนวน ๙๐๙,๙๙๒ บาท

เนื่องจากจะมีการปรับแผนกลางปี สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามไตรมาสหรือไม่ได้ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ส่งไฟล์แผนปี ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานปรับแผนกลางปี

๑.๔.๖ การจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขตหรือจังหวัด (PPA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยบริการ	MCH	NCD	Aging	รวมทั้งหมด
๑	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี	๓,๘๐๙.๖๕	๑,๐๒๑.๒๐	๓,๗๕๗.๒๐	๘,๕๘๘.๐๕
๒	รพ.สต.ลิ้นฟ้า	๑,๗๗๒.๘๑	๖,๘๔๐.๒๙	-	๘,๖๑๓.๑๐
๓	รพ.สต.กระเบื้องนอก	๒,๐๓๖.๘๔	๖๒,๕๑๕.๓๙	๑๑,๔๘๑.๔๖	๗๖,๐๓๓.๖๙
๕	รพ.สต.ครบุรี	๒,๔๑๔.๐๔	๖๘.๔๖	๖,๘๓๑.๒๖	๙,๓๑๓.๗๖
๖	รพ.สต.เมืองจาก	๒,๖๐๒.๖๔	๑๑.๔๑	๖,๓๐๔.๕๒	๘,๙๑๘.๕๗
รวมทั้งหมด		๑๒,๖๓๕.๙๘	๗๐,๔๕๖.๗๕	๒๘,๓๗๔.๔๔	๑๑๑,๔๖๗.๐๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔.๗ เงินปรับเกลี่ยตามเกณฑ์ สปสช. (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

ลำดับที่	กองทุน	งวด	จำนวนเงินจัดสรร (บาท)
๑	กองทุนผู้ป่วยนอก	OP สป.สธ. ปี ๒๕๖๙ ให้ครบร้อยละ ๙๕	๓,๖๓๙,๑๙๘.๘๐
๒	กองทุนผู้ป่วยใน	งบ IP เติมตามเกณฑ์ สธ. กรณี IP ร้อยละ ๕๐	๔,๐๑๗,๕๑๘.๘๘
๓	กองทุนผู้ป่วยใน	งบ IP เดิมตามเกณฑ์ สธ. กรณี PP ให้ครบรายรับ	๑๒๔,๖๔๘.๕๕
๔	กองทุนผู้ป่วยใน	งบ IP เดิมตามเกณฑ์ สธ. กรณี OP ให้ครบรายรับ	๒๓๒,๓๖๖.๘๙
๕	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	PP สป.สธ. ปี ๒๕๖๙ ให้ครบรายรับ	๘๗๘,๘๐๐.๘๒
รวมทั้งสิ้น			๘,๘๙๒,๕๓๓.๙๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๕ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

คุณสุภาพร : ๑.๕.๑ มีเจ้าหน้าที่ยื่นความประสงค์ขอย้ายภายใน CUP คือ นางสาวกฤษณา จำปาโพธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ รพ.สต.เมืองจาก โดยขออัตรากำลังพยาบาลทดแทน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๕.๒ มาตรการควบคุมวัณโรคจังหวัดนครราชสีมา “ไอ Fast Tract” (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๖ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

คุณแกมกาญจน์ : ผลการดำเนินงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) โดยมีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล จำนวน ๒ โครงการ คือ

(๑) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจ้าเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล

- <u>วัตถุประสงค์</u> : ๑. เพิ่มการเข้าถึงบริการระดับปฐมภูมิที่จำเป็นสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  ๒. ลดความแออัด ลดการรอคอยการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
- <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> : ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ OP : ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายเก่า ที่ต้องเจาะ LAB ก่อนพบแพทย์ตามนัด
- <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>

วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙ รพ.สต.ประเมินตัวเองจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน
วันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ รพ.สต.รับประเมินจากผู้ตรวจประเมินจาก สสจ.นม.
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ สสจ.นม.รับรองผลการประเมิน
เมษายน ๒๕๖๙ ขึ้นทะเบียนกับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(๒) Rational Laboratory Use, RLU: การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล

- <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>

ขั้นที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ (๙ ก.พ.๖๙), ประกาศเจตนารมณ์ (๕ มี.ค.๖๙)
ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูล, คัดเลือกโรคหรือภาวะที่เป็นปัญหา (๓๐ มี.ค.๖๙)
ขั้นที่ ๓ กำหนดมาตรการ, แนวทางลดการ Under/Over (เม.ย.๖๙)

ขั้นที่ ๔ ประกาศตัวชี้วัด (เม.ย.๖๙)

สรุปผลการดำเนินการ : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ณ ๓๐ ก.ย.๖๙)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๗ กลุ่มงานรังสีวิทยา

คุณนิภา : ๑.๗.๑ สปสช. โอนเงินกองทุน Central Reimburse สำหรับการพัฒนาระบบ AI CHEST จำนวน ๓๐๓,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๗.๒ อุบัติการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คือ เส้นเอ็นนิ้วมือข้างขวาอักเสบ จากการยกผู้ป่วยจากรถเข็น

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๘ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

คุณรัตนมุขย์ : ๑.๘.๑ รายการจ่ายอุปกรณ์ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๘.๒ การตัดรองเท้าเพื่อสุขภาพ

- สิทธิข้าราชการ รอบสุดท้ายจะตัดในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙
- สิทธิ UC เปิดจองผ่านระบบหมอพร้อม จำนวน ๑๐๐ คู่ ซึ่งจองเต็มแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๘.๒ ผลการดำเนินงานศูนย์สาธิตและยืมคืนอุปกรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๙ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คุณอิสระ : ๑.๙.๑ อัตราการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จาก สปสช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) จำนวนทั้งหมด ๑๐๖ รายการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๙.๒ เนื่องด้วยวันจันทร์ - วันอังคาร มีผู้ป่วย NCD มารับบริการพอกเข่าเป็นจำนวนน้อย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ จึงขอเพิ่มหัตถการในวันจันทร์ - วันอังคาร ในผู้ป่วย NCD คือ การประคบสมุนไพร

มติที่ประชุม รับทราบและให้นำเข้าที่ประชุมทีม PCT

๑.๙.๓ ขอติดตั้งเครื่องอ่าน Smart Card สำหรับปิดสิทธิ์ผู้มารับบริการที่กลุ่มงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑๐ กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

คุณปัฐวี : ๑.๑๐.๑ ทบทวนระเบียบบ้านพักเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าพักอาศัยเป็นไปตามระเบียบการเข้าพัก โดยอ้างอิงจากระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในบ้านพักโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับแก้ไข ๒๕๖๕) วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑๐.๒ แบบสำรวจรายการซ่อมบ้านพักโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)

มติที่ประชุม รับทราบ ๑. การซ่อมที่เป็นส่วนของโครงสร้างตัวอาคาร โรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบซ่อมแซมให้

๒. สำหรับวัสดุ/อุปกรณ์ ให้เจ้าของห้องพักดำเนินการซ่อมเอง

๑.๑๐.๓ สรุปยอดเงินคงเหลือแฟลต ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐๑,๑๐๗.๑๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑๐.๔ เกณฑ์การเข้าพักอาศัย

ลำดับที่	เกณฑ์การเข้าพัก	คะแนน		
๑.	ตำแหน่ง	วิชาชีพ (๕ คะแนน)	สนับสนุน (๐ คะแนน)	
๒.	อายุงาน	≥ ๑๐ ปี (๕ คะแนน)	> ๕ ปี (๓ คะแนน)	≤ ๕ ปี (๑ คะแนน)
๓.	ระยะทางระหว่างบ้านพักกับภูมิลำเนา(ที่อาศัยปัจจุบัน)	> 10 กม. (๕ คะแนน)	๖ กม. ถึง ๑๐ กม. (๓ คะแนน)	< ๕ กม. (๐ คะแนน)
๔.	เวลาปฏิบัติงาน(ขึ้นเวร)	เช้า บ่าย ดึก (๕ คะแนน)	เช้า บ่าย (๓ คะแนน)	เช้า +BD ถึง ๒๐.๐๐ น. (๑ คะแนน)

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้คณะกรรมการบ้านพักเพิ่มเกณฑ์การเข้าพักอาศัยติดต่อกัน ๑๕ วัน มาอีก ๑ ข้อ

๑.๑๑ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

คุณสันติภาพ : ๑.๑๑.๑ ข้อหารือขอห้องสำนักงาน Home ward เป็นห้องสำนักงานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

คุณศิรินทิพย์ : เนื่องจากผู้ปฏิบัติรอแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนจาก กกบ.รพ. ว่าการจัด Homeward ว่าเป็น Step down อย่างเดียวหรือไม่ และขอคอมพิวเตอร์สำหรับงาน Home ward

มติที่ประชุม รับทราบและ ๑. คืนห้องให้กลับกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

๒. Home ward จัดบริการแบบ Step down

๓. คอมพิวเตอร์มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปและงาน IT ตรวจสอบและบริหารจัดการให้เหมาะสม

๑.๑๑.๒ งบชดเชยงานมินิธัญญารักษ์ ยังไม่ได้รับการชดเชย กลุ่มงานได้จัดทำหนังสืออุทธรณ์ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑๑.๓ ติดตามการย้าย จ.๑๘ ของ นางวิยะดา เยี่ยมไธสง สามารถดำเนินการเขียนย้าย จ.๑๘ ได้เลยหรือไม่

คุณสุริวิภา : สามารถดำเนินการเขียนย้าย จ.๑๘ ได้

คุณศิรินทิพย์ : ติดตามการย้าย จ.๑๘ ของนางสาววิไล แว่นไธสง มาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา นางแก้วไพฑูรย์ แสนเพียร แทนนางวิยะดา เยี่ยมไธสง

มติทีประชุม มอบหมายงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

๑.๑๑.๔ ขอให้งาน IT จัดทำข้อมูลจำนวน Case มินิธัญญารักษ์ ลงใน Dash hoard MDC Daily

มติที่ประชุม มอบงาน IT ดำเนินการ

๑.๑๒ กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล

คุณศิว์วิศว์ : ๑.๑๒.๑ วาระติดตามของกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล

๑. ส่งภาพเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำบอร์ดโครงสร้างโรงพยาบาลใหม่ # อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ลงทะเบียนระบบ MMS เคลมประกันสังคม ระบบใหม่ # อยู่ระหว่างดำเนินการขอ User

๓. ขอสัญญาณ wifi เพิ่มที่ทันตกรรม # ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้หน้าห้องทันตกรรม

๔. ตรวจสอบ TOR งบค่าเสื่อมร่วมกับงานจัดซื้อจัดจ้าง # ส่ง SPEC ICT๖๙ เพื่อกำหนดคุณลักษณะแล้ว

๕. สาย LAN จุดบริการห้องตรวจเลือดใช้ไม่ได้ ๑ เส้น # บริษัทรับเหมาได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบแล้ว

๖. สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องอัพเกรด ปีงบ ๒๕๖๙ # อยู่ระหว่างดำเนินการขอให้แล้วเสร็จก่อนปรับแผนกลางปี

๗. ประสานระบบไฟฟ้า Server # ขอให้เพิ่มพาวเวอร์ปลั๊ก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

๘. การดำเนินการ HAIT # ประเมินข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้แล้วเสร็จก่อนจัดทำแผนปี ๒๕๗๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑๒.๑ การบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ปี ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม) จำนวนการให้บริการ ๓ ครั้ง เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นจุดให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่ รพ.สต.เพราะผู้ป่วยเปิด visit ที่ รพ.สต. และ รพ.สต.เป็นผู้คีย์เบิกค่าบริการ ดังนั้นขอให้กลุ่มงานที่มีการโทร Consult ผู้ป่วย ลงข้อมูลด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการ Telemedicine

มติที่ประชุม รับทราบ มอบงาน IT + งาน OPD ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและกำหนดแนวทางดำเนินงาน

๑.๑๒.๓ ขอขอบคุณกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคที่แบ่งปันพื้นที่ในการเก็บครุภัณฑ์ วัสดุ/อปุกรณ์ IT

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑๓ ทีมกีฬาและสันทนาการ

คุณสันติภาพ : ขอเลื่อนกำหนดการเปิดป้ายโรงพยาบาลและการจัดงานปีใหม่ จากเดิมวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองและติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

คุณสุริวิภา : ๒.๑ จากการสอบถามพนักงานบริการภาคสนาม เรื่อง การเก็บขยะ พบว่าปัญหาด้านสุขภาพทั้ง ๒ คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต่อ

๒.๒ ติดตามการปรับปรุง บิวท์อิน บริเวณด้านหน้าห้อง LAB จากการสอบถามช่างผู้รับผิดชอบแล้วแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนประตูเป็นแบบประตูบานเลื่อน จึงยังไม่ได้ดำเนินการ

คุณแกมกาญจน์ : ขอให้ปรับปรุง บิวท์อิน ฝั่งที่ติดกับห้องยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๓ ติดตามการซ่อมเต้าเสียบห้อง X-Ray ยังไม่ได้ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหน่วยงานต่างๆ

คุณสุริวิภา : ๑. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกข้าม CUP ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ซึ่งครอบคลุมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๘ (ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘)

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	จำนวน ๓๖,๐๙๖ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จำนวน ๖๐,๘๐๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด	จำนวน ๙๖,๙๐๔ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ

๒. ขออนุมัติตัดลูกหนี้เงินกองทุน สปสช.(UC) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เดือนมกราคม ๒๕๖๙			
๑.	เงินค่ารักษาพยาบาล OP (เบิกกรมบัญชีกลาง)	๙๘,๗๙๔.๖๕	
๒.	เงินค่ารักษาพยาบาล IP (เบิกกรมบัญชีกลาง)	๘๓,๖๒๘.๙๘	
๓.	เงินกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP)/DMOR/DKTP	๔๙,๐๗๐.๐๐	
๔.	เงินกองทุน CENTRAL REIMBURSE	๑๓๘,๗๖๑.๐๐	
๕.	เงินกองทุน Aids DNAP	๔๐.๐๐	
๖.	เงินงบบริการแพทย์แผนไทย	๔๘,๓๙๒.๐๐	
๗.	เงินค่ารักษาพยาบาล IP/UC	๑,๔๑๔,๒๘๑.๕๑	
๘.	เงินกองทุนผู้ป่วยนอก OP สป.สช. ปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓	๔,๐๘๔,๒๖๕.๕๑	
๙.	เงินกองทุนผู้ป่วยใน IP สป.สช. ปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓	๖๙๗,๑๐๐.๖๙	
๑๐.	เงินกองทุนผู้ป่วยใน PP สป.สช. ปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓	๓๗๓,๙๔๕.๖๗	
๑๑.	เงินกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP สป.สธ. ปี ๒๕๖๙	๖๒๙,๕๐๒.๔๕	
รวม	(เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสอบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)	๗,๖๑๗,๗๘๒.๔๑	

มติที่ประชุม อนุมัติ

คุณรัตนมุขย์ : ขออนุมัติใช้เงินบำรุงสมทบจำนวน ๕,๘๐๐ บาท เพื่อซื้อเตียงฟาวเลอร์ ๒ ไก เพิ่มจำนวน ๒ เตียง ถ้าซื้อ ๑ เตียง ต้องคืนเงิน ๘,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ

คุณอิสระ : ขออนุมัติจัดทำอัตราการเบิกจ่ายยาสมุนไพรในระบบ HOSxP ให้ตรงกับอัตราการเบิกจ่ายค่าสมนุไพรของ สปสช.

มติทีประชุม อนุมัติ และให้นำเข้าที่ประชุมทีม PTC

คุณศิว์วิศว์ : ขอทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานให้บริการนอกเวลาราชการเวรเช้าวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากการสำรวจค่าตอบแทนโรงพยาบาลในจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖) จากเดิมเบิกตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ขออนุมัติเบิกตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม อนุมัติให้เบิกตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

.....
(นางสาวปธิตา แว่นไธสง)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์

.....
(นางศิรินทิพย์ โกนสันเทียะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจทาน
19 มี.ค. 2569

ชอบ

.....
(นายนพชัย ประสงค์สุธน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี

แผนพัฒนาเพื่อลดการรอคอย OPD ปี 2569

หมวดบริการ	ประเด็นปัญหาจากการทบทวน	กิจกรรม/แผนพัฒนา	เดือน ช่วงเวลา สามารถดำเนินการได้ใน แต่ละกิจกรรม
1. ระยะรอคัดกรอง	1. ผู้ป่วยที่เดินทางมาพร้อมกันจำนวนมาก 2. ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจทั่วไปห้องบัตรเริ่มส่งคิวเข้ารับบริการประมาณ 06.00 น. แต่พยาบาลจะเริ่มซักประวัติคนแรกประมาณ 8.00 น. 3.ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจคลินิกโรคเรื้อรังห้องบัตรเริ่มส่งคิวเข้ารับบริการประมาณ 06.00 น. แต่พยาบาลจะเริ่มซักประวัติคนแรกประมาณ 8.00 น.	1.จัดทำ flow รับบริการภาพรวม รพ. 2.จัดทำ flow รับบริการหน่วยงาน 3.กำหนดให้ พยาบาลเวรดึก ER รับผิดชอบ screen OPD เวลา07.00น. 4.จัดพยาบาลขึ้นเวร ให้บริการผู้ป่วย คลินิกโรคเรื้อรัง เริ่ม 07.00น. 5. ล็อคจำนวนผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่เกิน 90 คน /วัน 6.แยกคลินิก NCD ออกจาก OPD	เริ่ม มีนาคม 69
2. ระยะคัดกรอง	1.ผู้รับบริการกลุ่ม High Volumn (DM,HT) มารับบริการช่วงเวลาเดียวกัน	1.ปรับเวลาซักประวัติเร็วขึ้น เริ่มเวลา 7.00 น.	เริ่ม มีนาคม 69

3. ระยะรอพบแพทย์	1.แพทย์ที่ได้รับมอบหมายตรวจผู้ป่วย ER และ OPD ถ้ามี case ฉุกเฉินที่ ER จะใช้เวลานาน ทำให้ผู้ป่วยทั่วไปมีระยะเวลารอพบแพทย์นานขึ้น 2. แพทย์บางคนออกตรวจช้า ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์ท่านนั้น นัดมา F/U ต้องรอนาน 3. วันที่แพทย์ติดประชุม ลา ไม่มีแพทย์ที่หน่วยงานอื่นมาช่วยตรวจ จากการทบทวนระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก พบว่าในปี 2565 และ 2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 4.ระบบการ round ผู้ป่วยในแพทย์เข้าไปราวน์พร้อมกัน ออกตรวจผู้ป่วยนอกล่าช้า 5.แพทย์มีภารกิจการตรวจผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในวันจันทร์และวันอังคารช่วงเช้า	1. แพทย์ทุกคนควรออกตรวจ OPD NCDไม่เกิน 8.30 น. 2. หากแพทย์ประชุม/ลา ประสานจัดหาแพทย์จากหน่วยงานอื่นมาช่วยตรวจในช่วงเวลาเร่งด่วน (08.30-12.00) 3. กรณีแพทย์ออกตรวจน้อย เนื่องจากติดภารกิจ พยาบาลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยทราบเป็นระยะๆ ทุก 15-30 นาที เพื่อลดความกังวล 4.แพทย์จัดเวรราวด์วอร์ดผู้ป่วยในสลับกันครั้งละ 1 คน และให้มีแพทย์ตรวจผู้ป่วยนอกตั้งแต่เวลา 08.00 น. อย่างน้อย 1 คน 5.กำหนดระบบนัดผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการนัดช่วงเช้าวันจันทร์และวันอังคาร อังคารที่แพทย์ออกตรวจคลินิกเบาหวานละความดันโลหิตสูง	เริ่ม มีนาคม 69
4. ระยะพบแพทย์	ระยะเวลาเหมาะสม	ไม่มี	
5. ระยะรอรับยา			
6. ระยะรอ X-ray	ระยะเวลาเหมาะสม	ไม่มี	
7. ระยะรอตรวจ LAB	1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังคลินิกเบาหวานรอเจาะเลือดนาน เนื่องจากต้องรอซักประวัติก่อนถึงจะได้ไป เจาะเลือด เนื่องจาก ระบบไม่ขึ้นLab ล่วงหน้า ต้องรอให้พยาบาลยืนยันสั่ง Lab ก่อน	1.ประสาน IT แก้ไขระบบการแจ้ง labล่วงหน้า 2.ปรับระบบให้ผู้ป่วยเจาะเลือดก่อนซักประวัติ 3.ปรับเวลาการเริ่มเจาะlab จาก7.30น.เป็น7.00น.	

เอกสารหมายเลข 2

โปรแกรมการแข่งขันเปตองคู่ผสม "เปตองเมืองยางเกมส์" ประจำ ปี ๒๕๖๙

งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอเมืองยาง ประจำปี ๒๕๖๙

อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

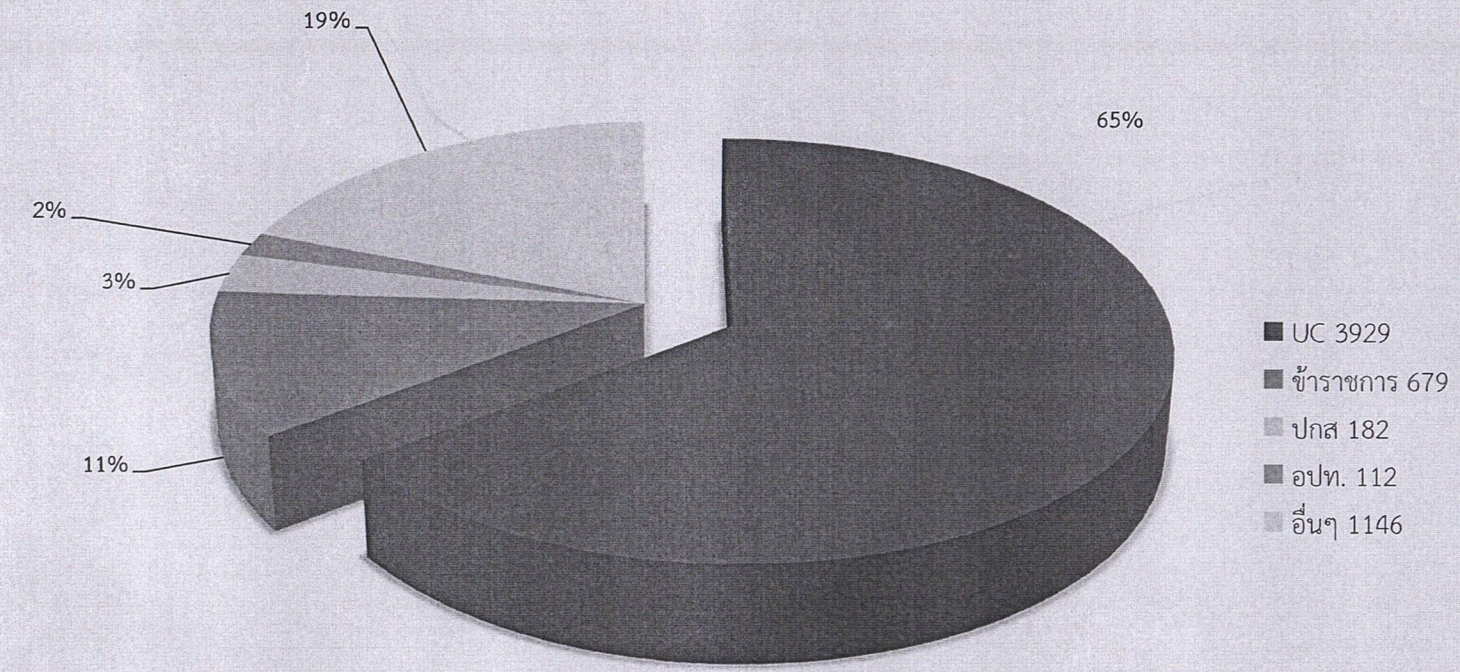
วันที่ ๑๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ สนามเปตองอำเภอเมืองยาง

สาย A	สาย B	สาย C	สาย D
๑.ปกครองอำเภอเมืองยาง	๕.ชมรมกำนัน ต.เมืองยาง	๙.ชมรมกำนัน ต.กระเบื้องฯ	๑๓ สกร.เมืองยาง
๒.ชมรมครูอำเภอเมืองยาง	๖.โรงพยาบาลเมืองยาง๑	๑๐.ชมรมกำนัน ต.ละหานฯ	๑๔.อบต.กระเบื้องนอก
๓.เทศบาลตำบลเมืองยาง	๗.ชมรมกำนัน ต.โนนอุดม	๑๑.สภ.เมืองยาง	๑๕ โรงพยาบาลเมืองยาง๒
๔.ปศุสัตว์+เกษตร+ท้องถิ่น	๘.อบต.โนนอุดม	๑๒.อบต.ละหานปลาค้าว	๑๖ .สาธารณสุข อ.เมืองยาง

คู่ที่	วัน เวลา ที่แข่งขัน	ทีม	ผลการแข่งขัน	หมายเหตุ
๑ ๒ ๓ ๔	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.	(๑)ปกครองอำเภอเมืองยาง vs ชมรมครูอำเภอเมืองยาง(๒) (๓)เทศบาลตำบลเมืองยาง vs ปศุสัตว์+เกษตร+ท้องถิ่น(๔) (๕)ชมรมกำนัน ต.เมืองยาง vs โรงพยาบาลเมืองยาง๑ (๖) (๗)ชมรมกำนัน ต.โนนอุดม vs อบต.โนนอุดม (๘)		สนามที่๑
๕ ๖ ๗ ๘	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น	(๙)ชมรมกำนัน ต.กระเบื้องฯ vs ชมรมกำนัน ต.ละหานฯ(๑๐) (๑๑)สภ.เมืองยาง vs อบต.ละหานปลาค้าว(๑๒) (๑๓)สกร.เมืองยาง vs อบต.กระเบื้องนอก(๑๔) (๑๕)โรงพยาบาลเมืองยาง๒ vs สาธารณสุข อ.เมืองยาง (๑๖)		สนามที่๒
๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น	(๖)โรงพยาบาลเมืองยาง๑ vs อบต.โนนอุดม (๘) (๕)ชมรมกำนัน ต.เมืองยาง vs ชมรมกำนัน ต.โนนอุดม(๗) (๒)ชมรมครูอำเภอเมืองยาง vs ปศุสัตว์+เกษตร+ท้องถิ่น(๔) (๑)ปกครองอำเภอเมืองยาง vs เทศบาลตำบลเมืองยาง (๓)		สนามที่๒
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น	(๑๔)อบต.กระเบื้องนอก vs สาธารณสุข อ.เมืองยาง (๑๖) (๑๓)สกร.เมืองยาง vs โรงพยาบาลเมืองยาง๒ (๑๕) (๑๐)ชมรมกำนัน ต.ละหานฯ vs อบต.ละหานปลาค้าว(๑๒) (๙)ชมรมกำนัน ต.กระเบื้องฯ vs .สภ.เมืองยาง.(๑๑)		สนามที่๑
๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น	(๑)ปกครองอำเภอเมืองยาง vs ปศุสัตว์+เกษตร+ท้องถิ่น (๔) (๒)ชมรมครูอำเภอเมืองยาง vs .เทศบาลตำบลเมืองยาง(๓) (๕)ชมรมกำนัน ต.เมืองยาง vs อบต.โนนอุดม (๘) (๖) .โรงพยาบาลเมืองยาง๑ vs ชมรมกำนัน ต.โนนอุดม(๗)		สนามที่๑
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น	(๙) .ชมรมกำนัน ต.กระเบื้องฯ vs อบต.ละหานปลาค้าว (๑๒) (๑๐)ชมรมกำนัน ต.ละหานฯ vs สภ.เมืองยาง(๑๑) (๑๓)สกร.เมืองยาง vs สาธารณสุข อ.เมืองยาง(๑๖) (๑๔)อบต.กระเบื้องนอก vs โรงพยาบาลเมืองยาง๒ (๑๕)		สนามที่๒
๒๕ ๒๖	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น	ที่ ๑ สาย A vs ที่ ๒ สาย B ที่ ๒ สาย A vs ที่ ๑ สาย B		สนามที่๑
๒๗ ๒๘		ที่ ๑ สาย C vs ที่ ๒ สาย D ที่ ๒ สาย C vs ที่ ๑ สาย D		สนามที่๒
๒๙	เวลา ๑๔.๐๐ น	ชนะคู่ที่ ๒๕ vs ชนะคู่ที่ ๒๗		สนามที่๑
๓๐	เวลา ๑๔.๐๐ น	ชนะคู่ที่ ๒๖ vs ชนะคู่ที่ ๒๘		สนามที่๒
๓๑		แพ้คู่ที่ ๒๙ vs แพ้คู่ที่ ๓๐		สนามที่๑
๓๒		ชนะคู่ที่ ๒๙ vs ชนะคู่ที่ ๓๐		สนามที่๒

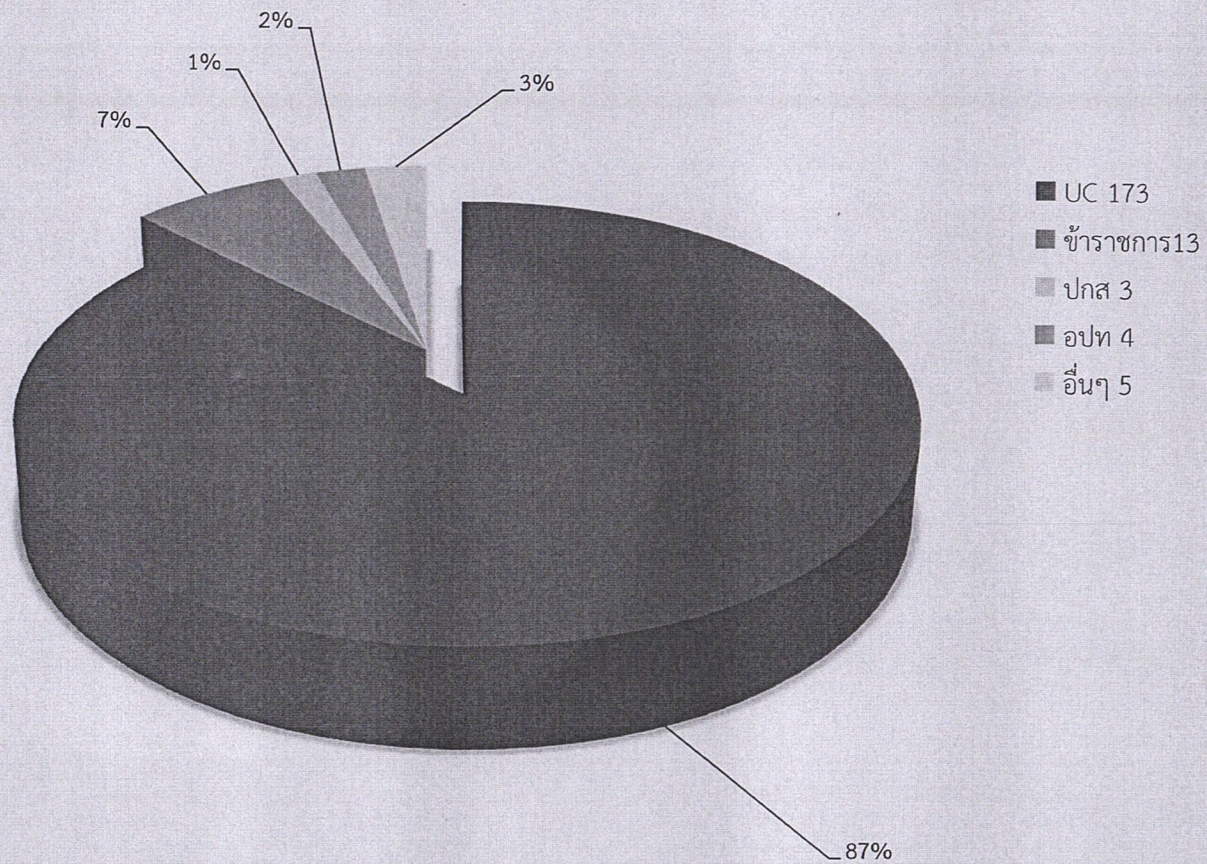
เอกสารหมายเลข 6

กราฟแสดงการมารับบริการผู้ป่วยนอกแยกตามสิทธิ เดือน กุมภาพันธ์ 2569



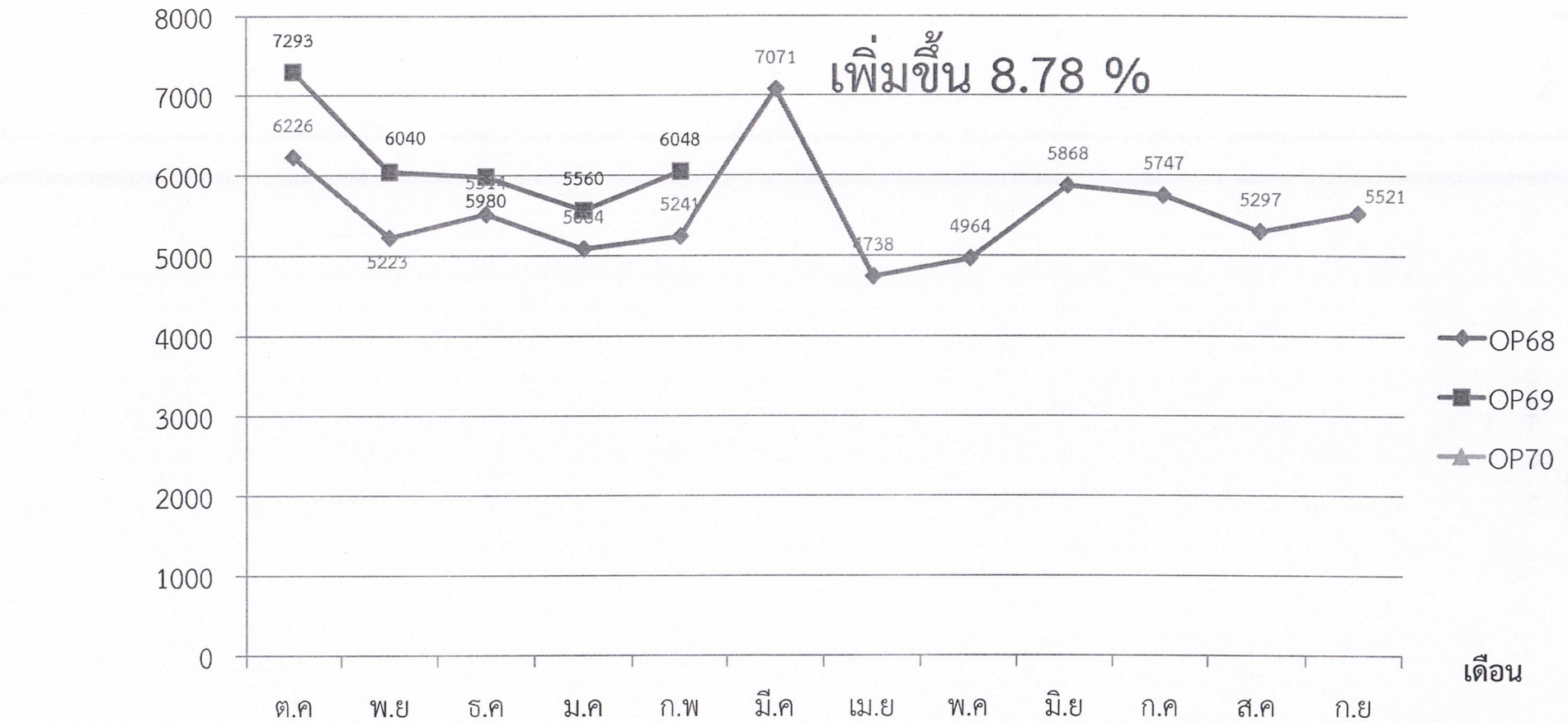
รวมทั้งหมด 6,048 ครั้ง

กราฟแสดงการมารับบริการผู้ป่วยในแยกตามสิทธิ เดือน กุมภาพันธ์ 2569



รวมทั้งหมด 198 ครั้ง

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2569

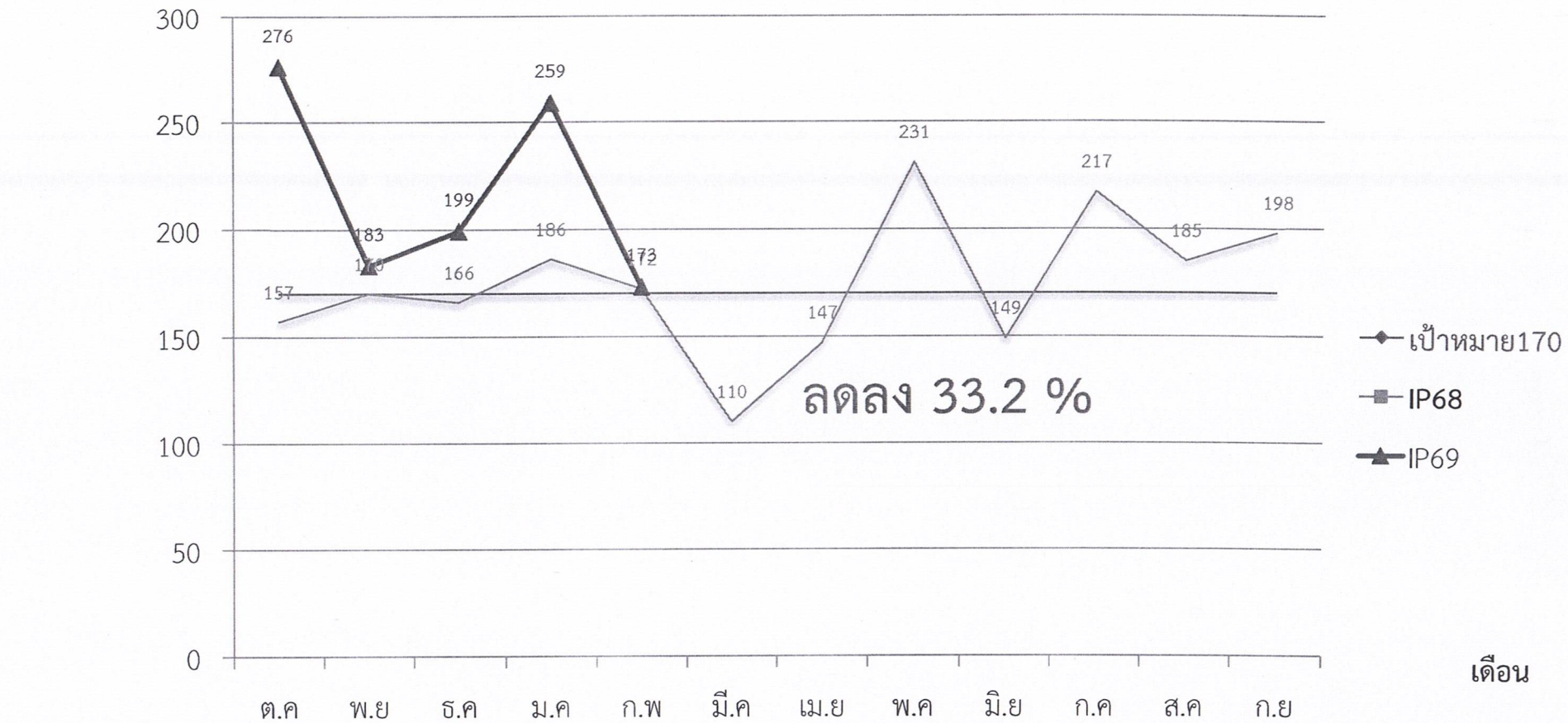


ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

ผู้ป่วยนอก ปี 2568 66,494 ครั้ง , เฉลี่ย 5,541 ครั้ง/เดือน

ผู้ป่วยนอก ปี 2569 30,921 ครั้ง , เฉลี่ย 7,730 ครั้ง/เดือน

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569

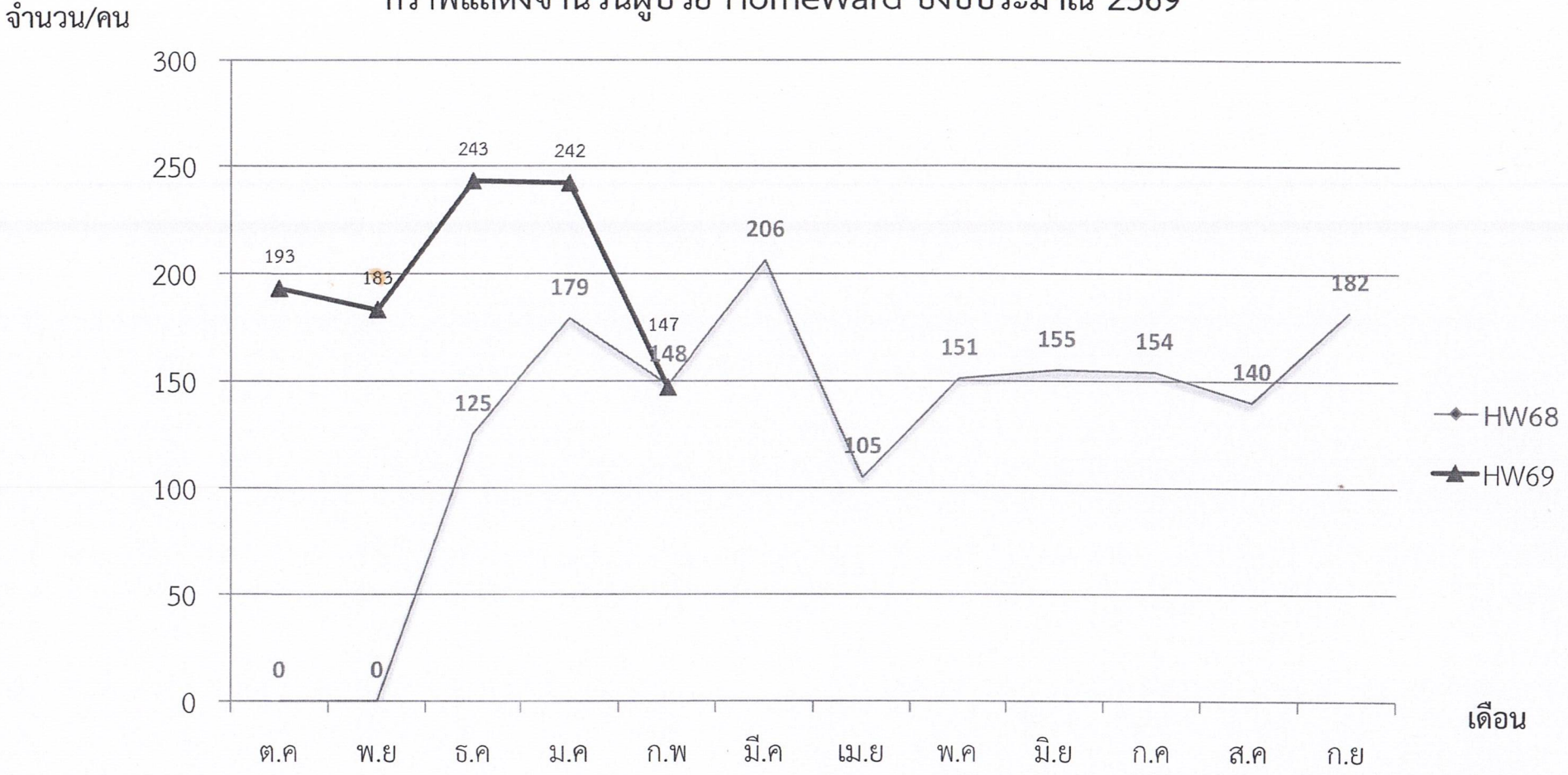


ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ 100 ปี

ผู้ป่วยใน ปี 2568 2,088 ครั้ง , เฉลี่ย 174 ครั้ง/เดือน

ผู้ป่วยใน ปี 2569 1,090 ครั้ง , เฉลี่ย 218 ครั้ง/เดือน

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย HomeWard ปีงบประมาณ 2569

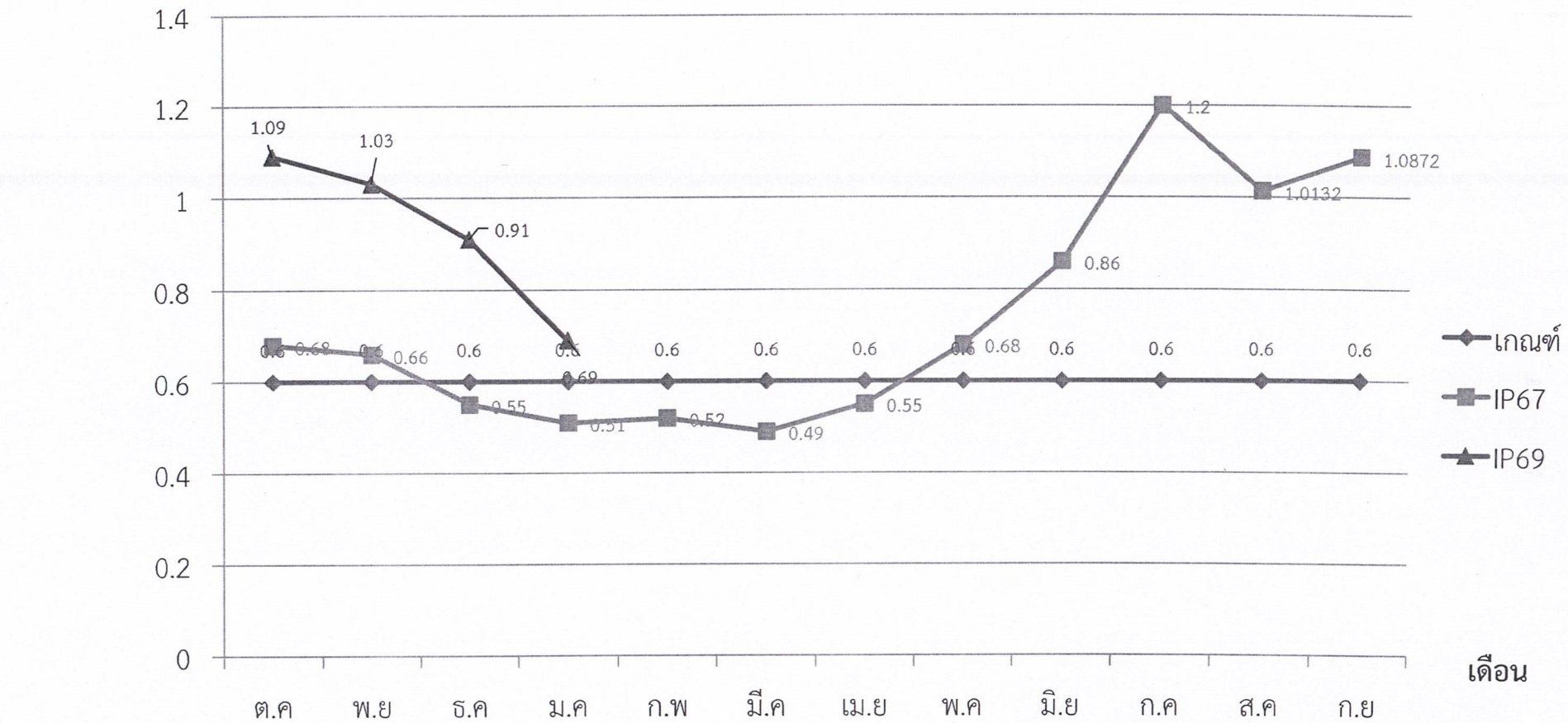


ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

ผู้ป่วย HW ปี 2568 1,454 ครั้ง , เฉลี่ย 154 ครั้ง/เดือน

ผู้ป่วย HW ปี 2569 1,008 ครั้ง , เฉลี่ย 201 ครั้ง/เดือน

กราฟแสดงข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2569

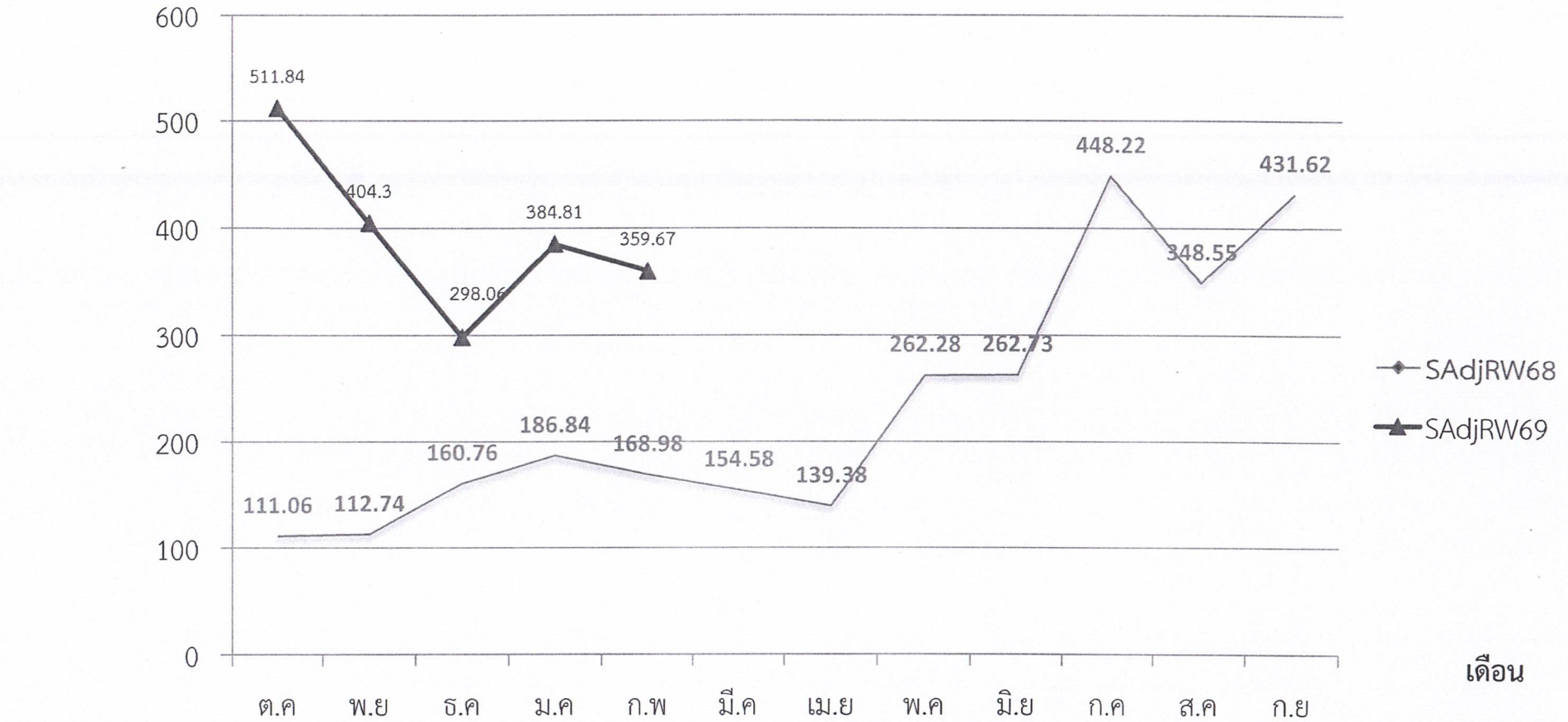


ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

CMI ปีงบประมาณ 2568 เฉลี่ย 0.73

CMI ปีงบประมาณ 2569 เฉลี่ย 1.06

กราฟแสดงจำนวน SumAdjRW ปีงบประมาณ 2569

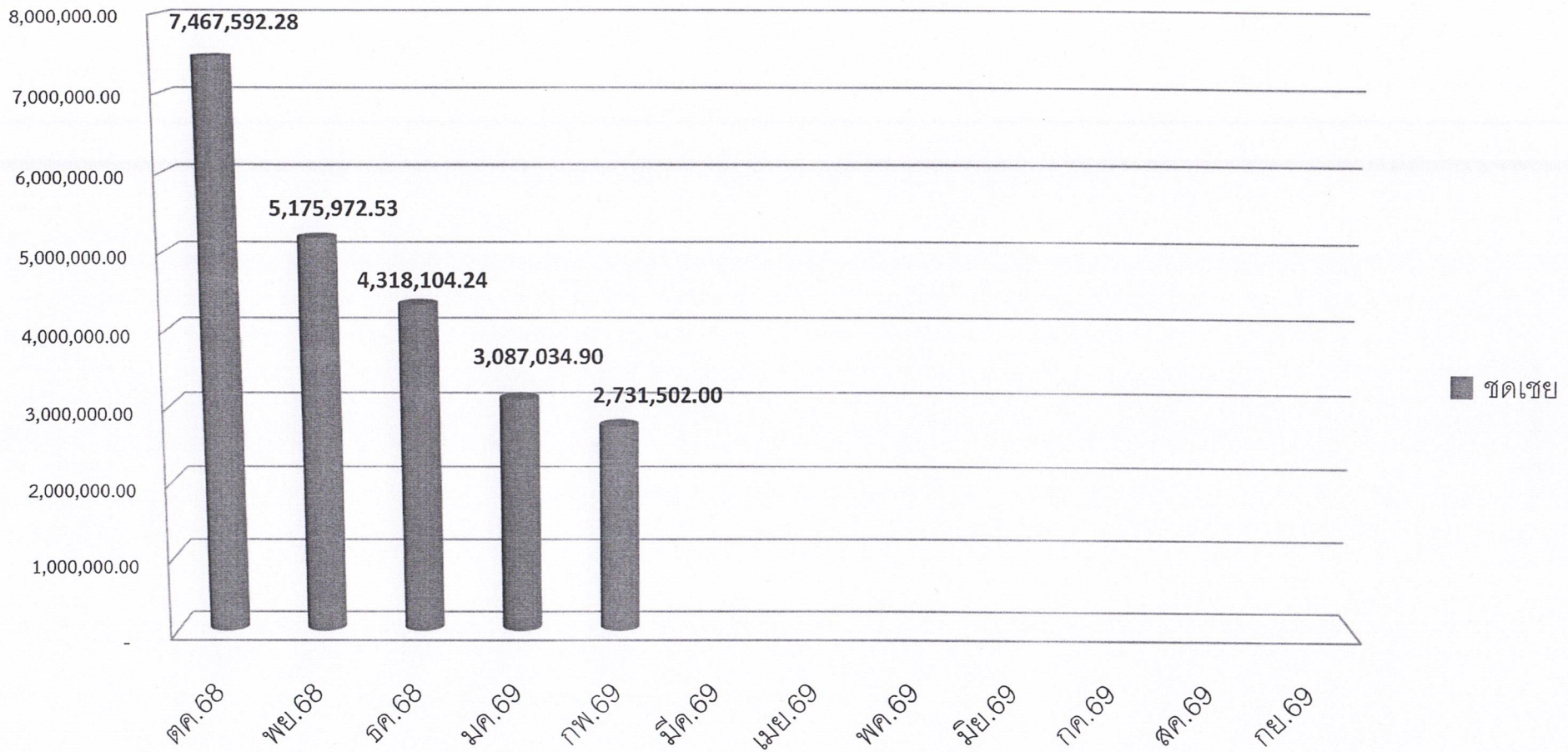


ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

ผู้ป่วย SumAdjRW ปี 2568 2,787.74 , เฉลี่ย 232.31 /เดือน

ผู้ป่วย SumAdjRW ปี 2569 1,958.68 , เฉลี่ย 391.6 /เดือน

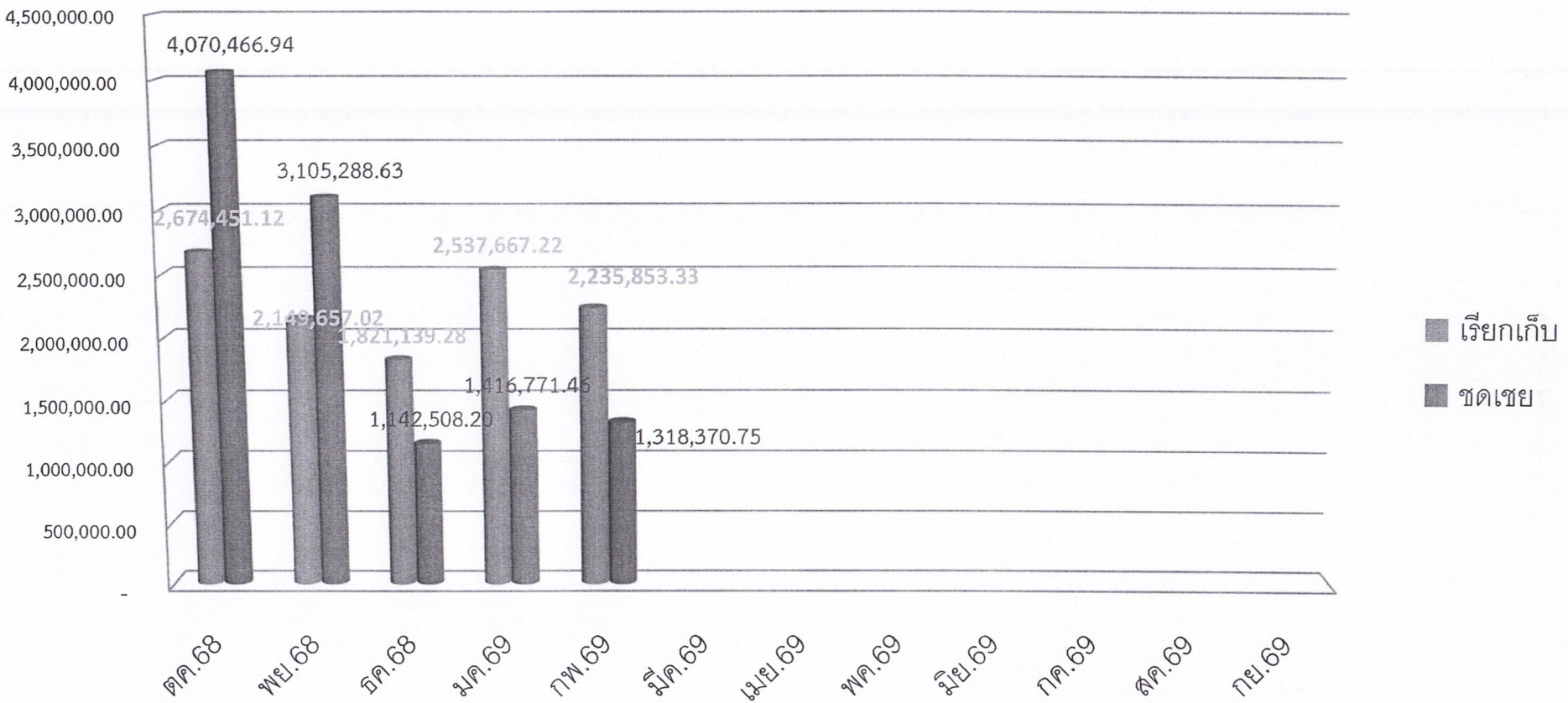
พึงรับชดเชยตามรอบ Statement รายเดือน OP,IP ปีงบประมาณ 2569



รวมชดเชย OP,IP 2568 22,780,205 บาท

เฉพาะส่วนที่ประมวลผลผ่านระบบ E-Claim

ข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยใน สิทธิ UC ปีงบประมาณ 2569



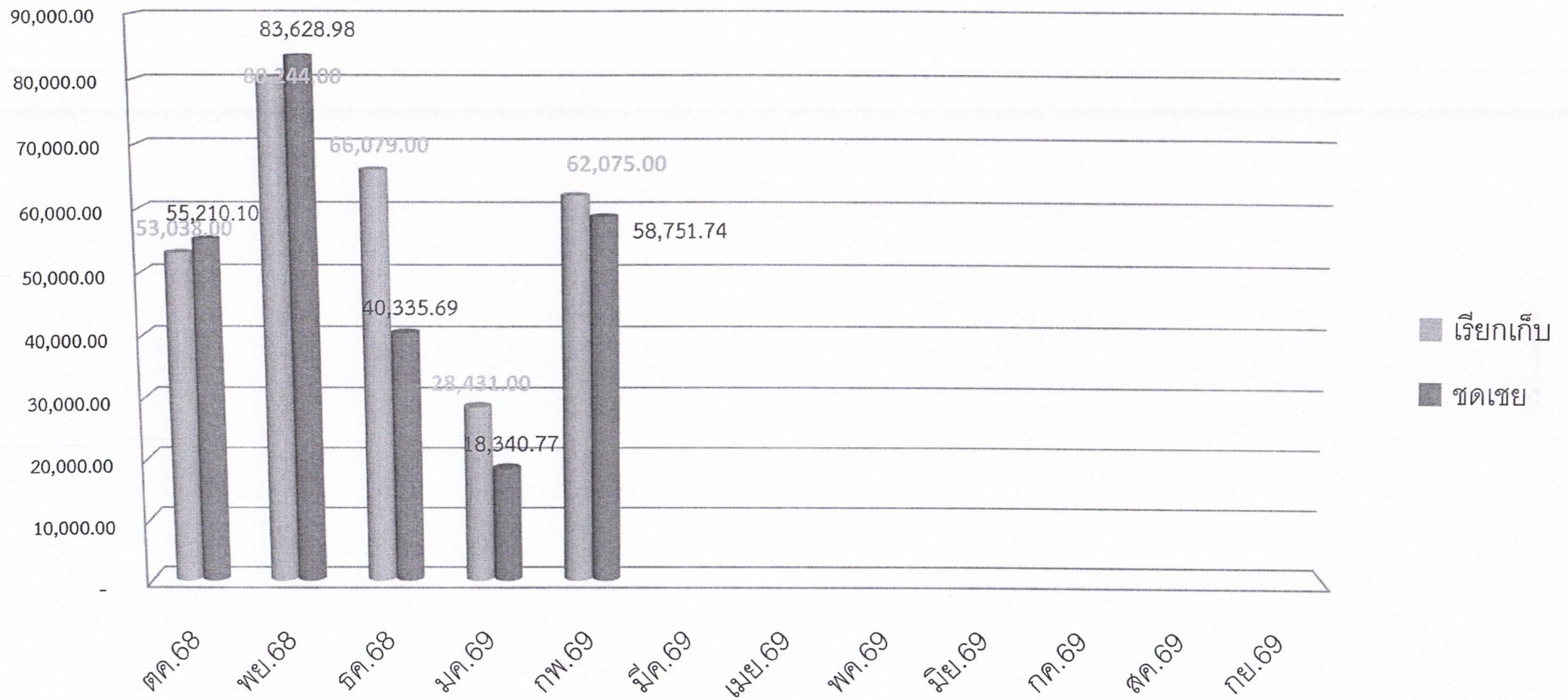
รวมเรียกเก็บ IP 2569 11,418,767 บาท

รวมชดเชย IP 2569 11,053,405 บาท

ส่วนต่าง + 365,361 บาท

(หักเงินเดือน 521,325.30 บาท/เดือน)

ข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการ ปีงบประมาณ 2569



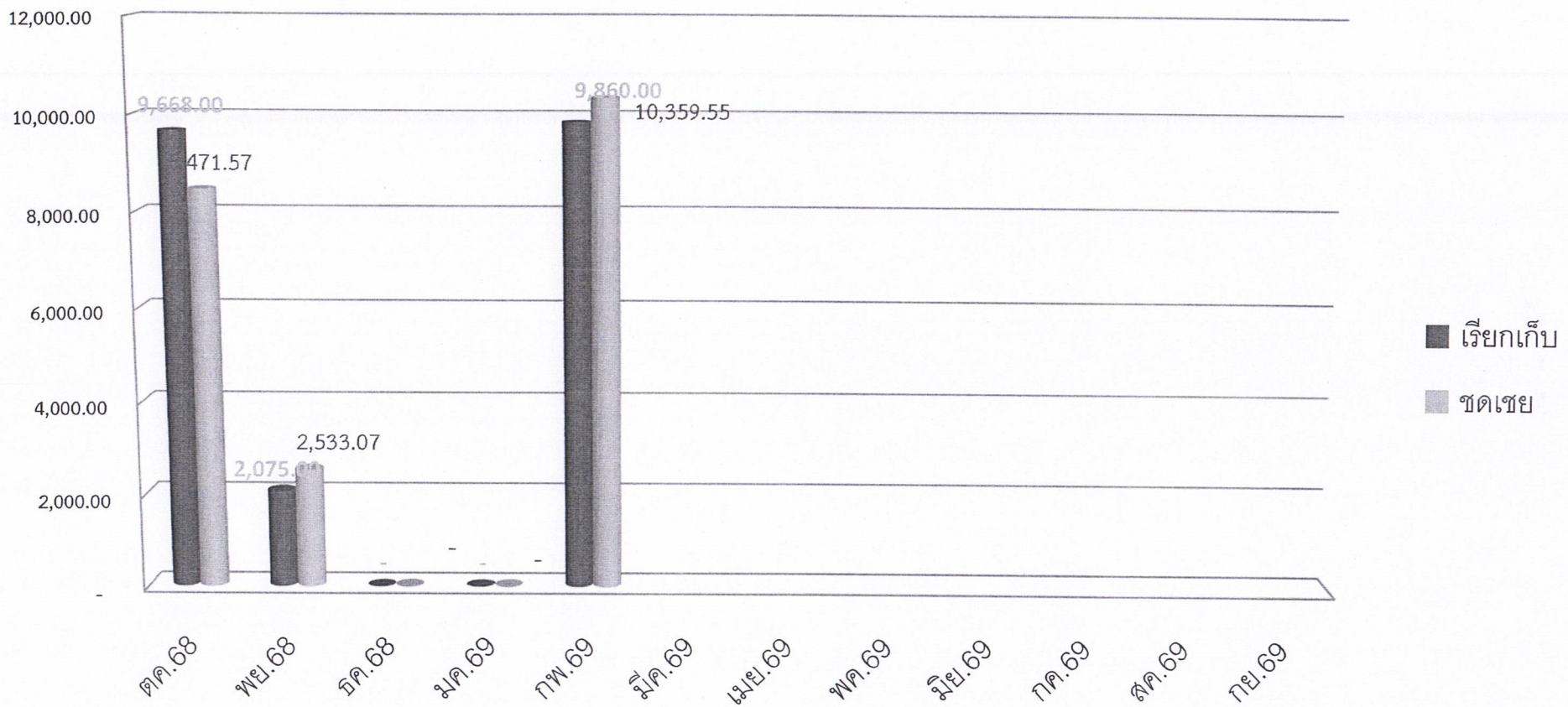
รวมเรียกเก็บ IP 2569 289,867 บาท

รวมชดเชย IP 2569 256,267 บาท

ส่วนต่าง -33,599 บาท

รวมชดเชย IP 2568 879,358 บาท

ข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2569



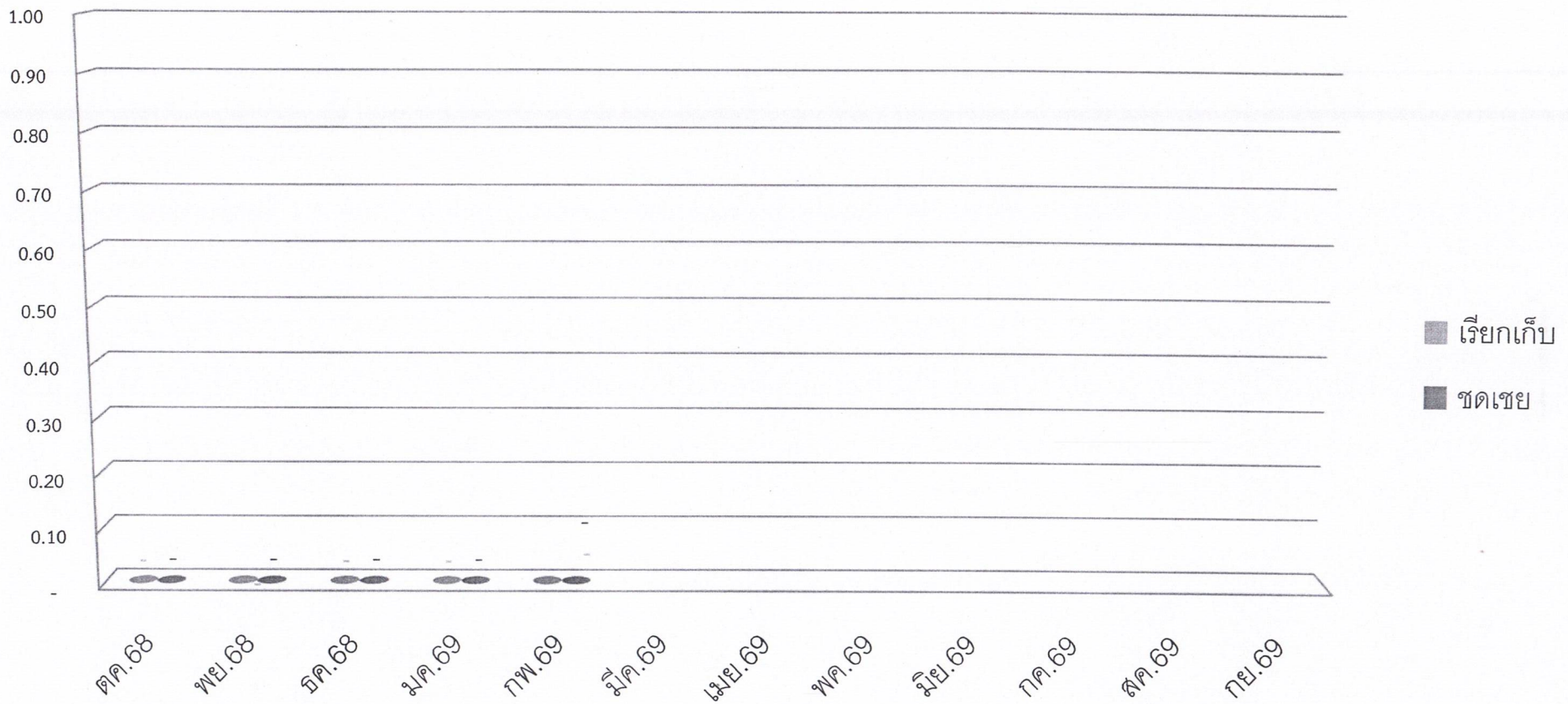
รวมเรียกเก็บ IP 2569 21,603 บาท

รวมชดเชย IP 2569 21,364 บาท

ส่วนต่าง - 238 บาท

รวมชดเชย IP 2568 104,358 บาท

ข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการ กทม. ปีงบประมาณ 2569



รวมเรียกเก็บ IP 2569 0 บาท

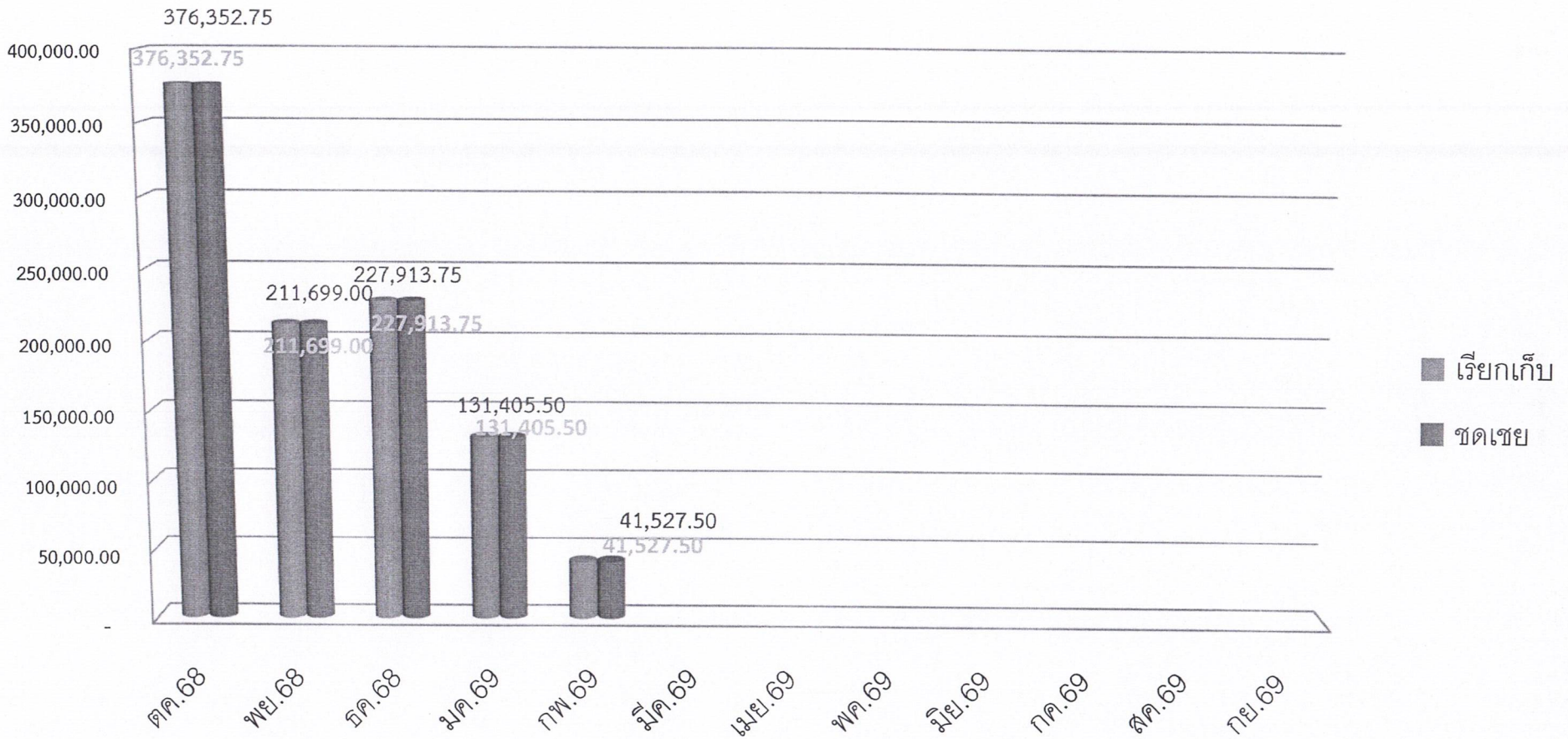
รวมชดเชย IP 2569 0 บาท

ส่วนต่าง +0 บาท

รวมชดเชย IP 2568 28,893 บาท

ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

ข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ปีงบประมาณ 2569



รวมเรียกเก็บ OP 2569 988,898 บาท

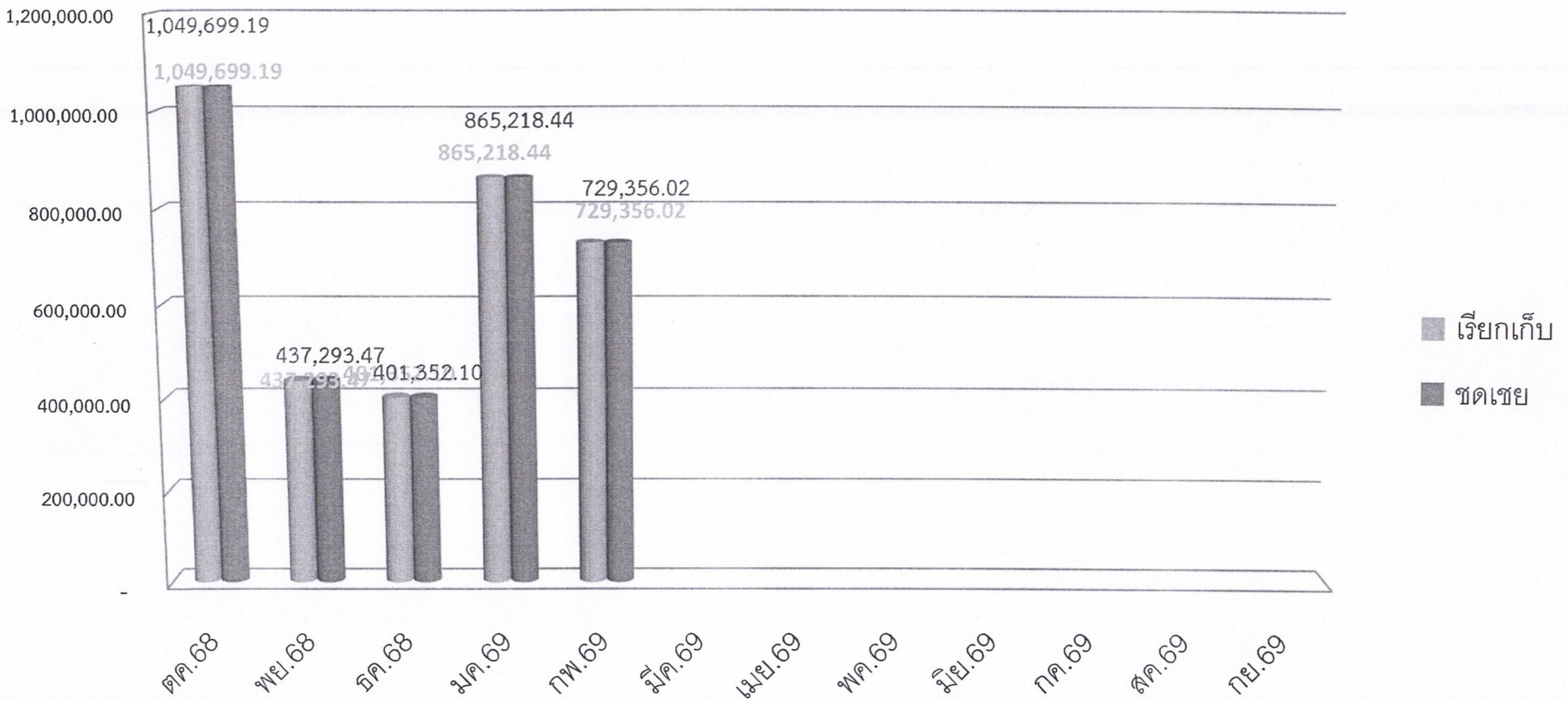
รวมชดเชย OP 2569 988,898 บาท

ส่วนต่าง + 0 บาท

รวมชดเชย OP 2568 3,323,188 บาท

ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

ข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยนอก สิทธิข้าราชการ ปีงบประมาณ 2569



รวมเรียกเก็บ OP 2569 3,482,919 บาท

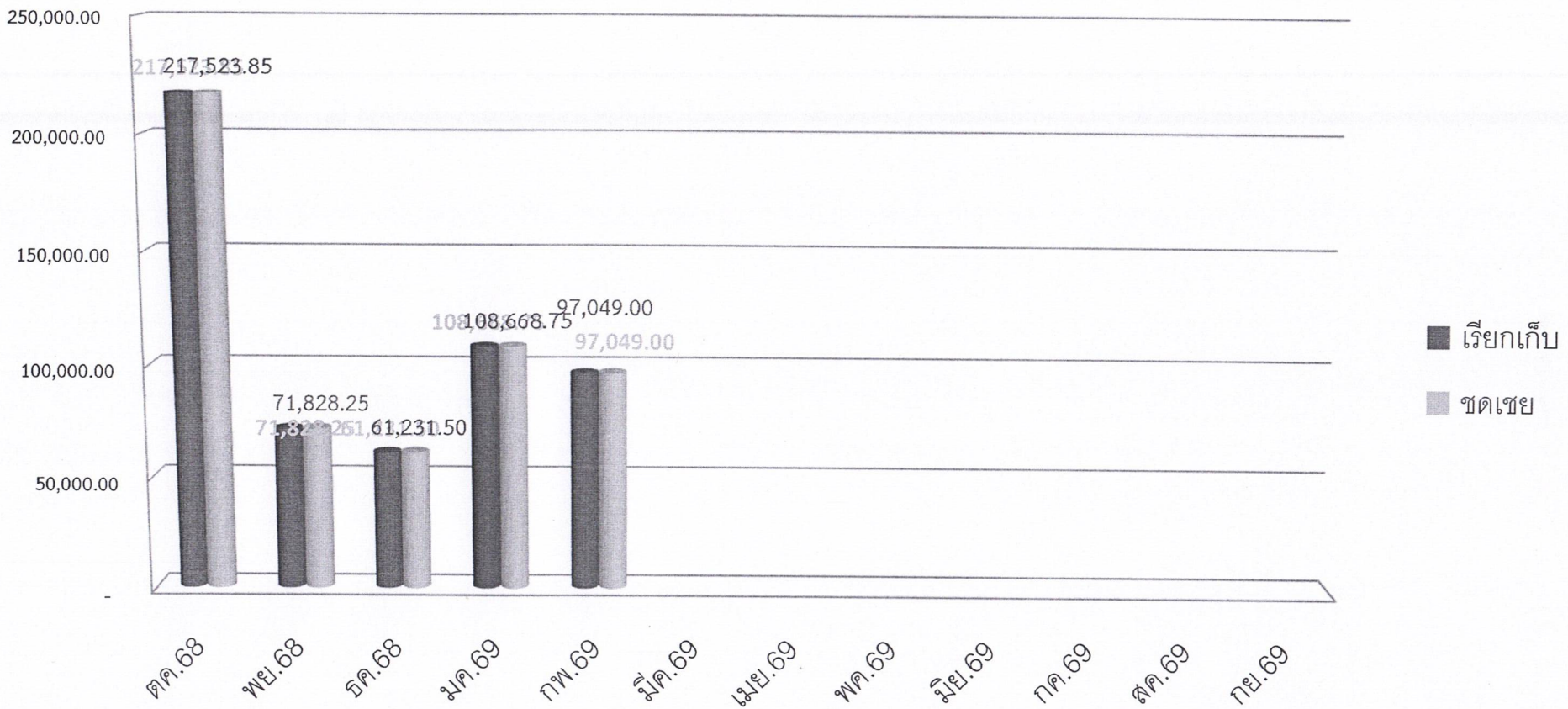
รวมชดเชย OP 2569 3,482,919 บาท

ส่วนต่าง +0 บาท

รวมชดเชย OP 2568 8,599,684 บาท

ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

ข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยนอก สิทธิข้าราชการท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2569



รวมเรียกเก็บ OP 2569 556,301 บาท

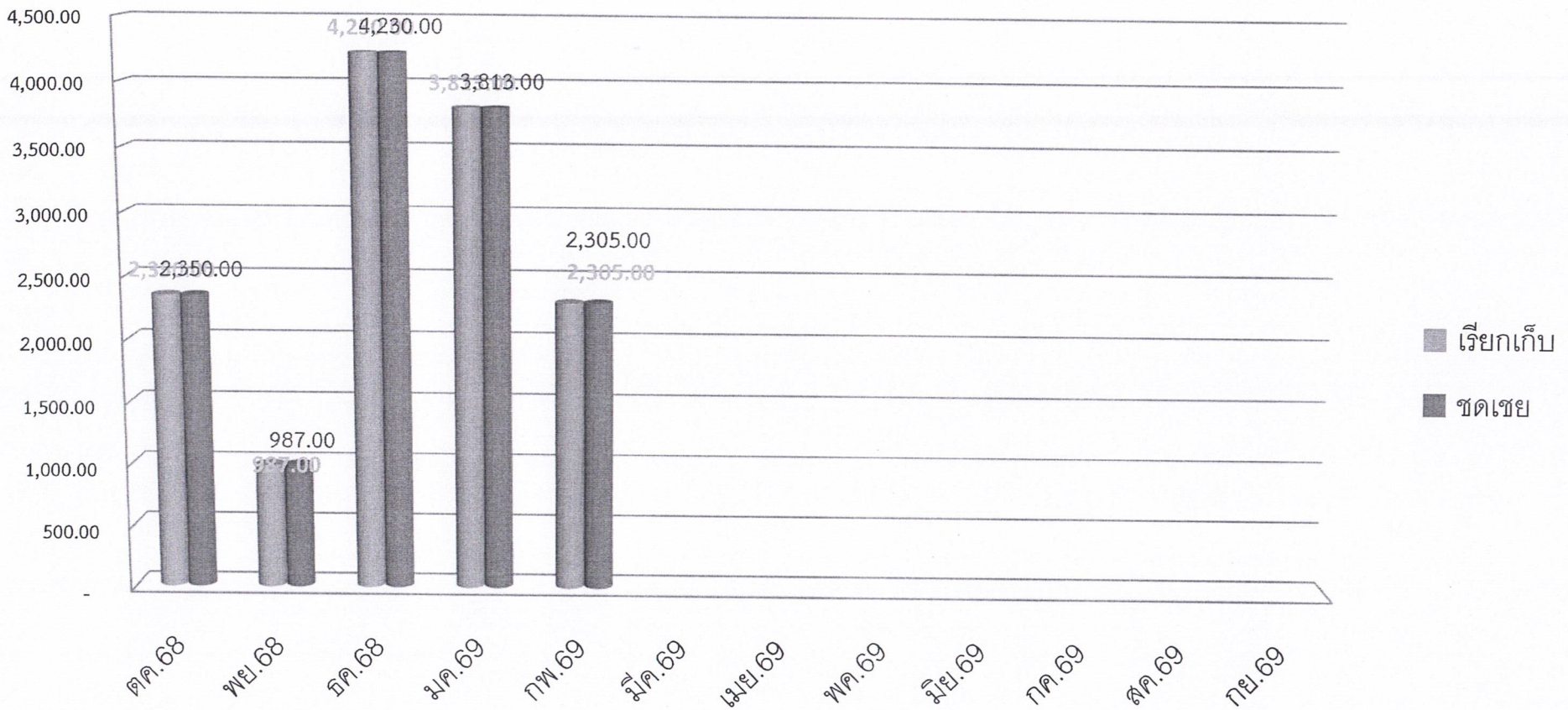
รวมชดเชย OP 2569 556,301 บาท

ส่วนต่าง +0 บาท

รวมชดเชย OP 2568 1,262,776 บาท

ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

ข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยนอก สิทธิข้าราชการ กทม. ปีงบประมาณ 2569



รวมเรียกเก็บ OP 2569 13,685 บาท

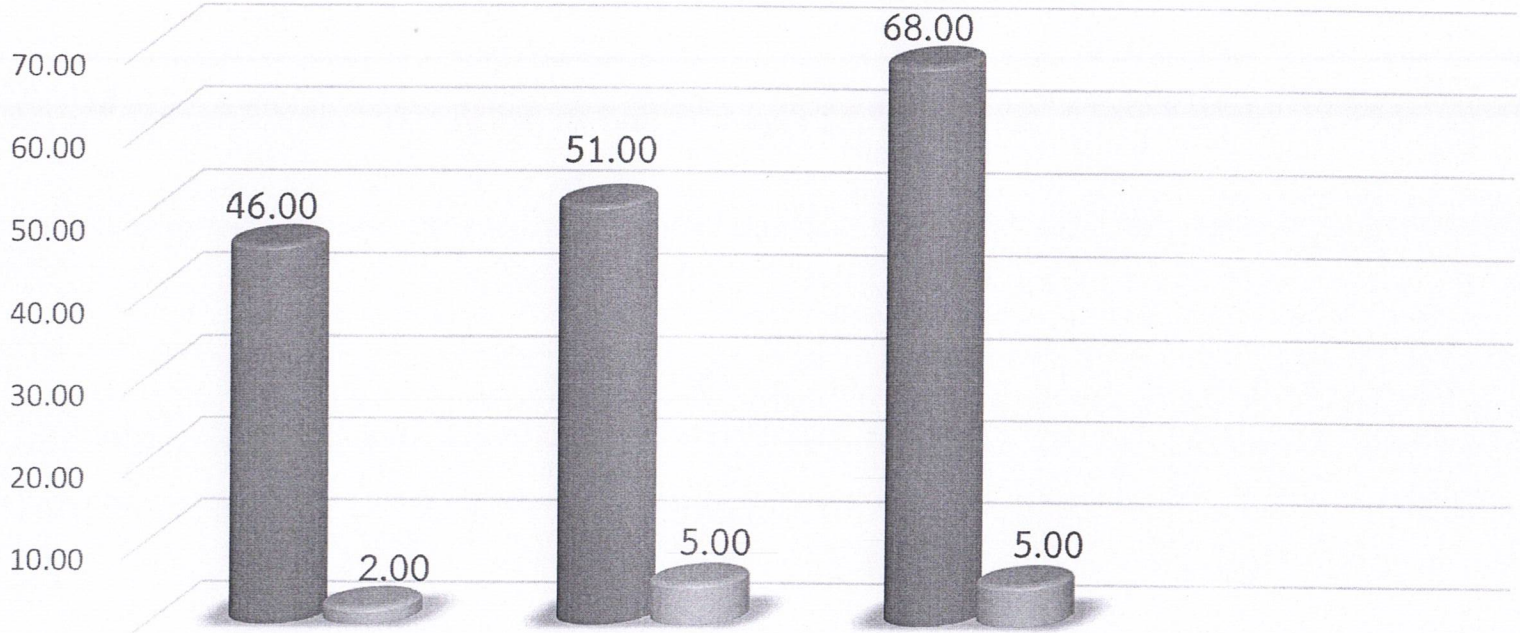
รวมชดเชย OP 2569 13,685 บาท

ส่วนต่าง 0 บาท

รวมชดเชย OP 2568 88,207 บาท

ที่มา : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

ข้อมูลผู้มารับบริการเวรดึก เวลา 00.00 – 05.59 น.



	ธค.68	มค.69	กพ.69	
คนไข้ปกติ	46.00	51.00	68.00	
คนไข้รถนั่ง-รถนอน	2.00	5.00	5.00	

กรณีถ้าจ้างเวรดึกห้องบัตร คิดเป็น 360*31 =11,160 บาท

ที่มา : สมุดลงข้อมูลปฏิบัติงานเวรเปล,HosXP

เอกสารหมายเลข 4

(ร่าง)

ข้อสั่งการ/มอบนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง มาตรการควบคุมวัณโรคจังหวัดนครราชสีมา

.....

ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.จัดระบบบริการทางด่วน "ไอ Fast tract" โดยการซักประวัติผู้ป่วยทุกประเภทที่มีประวัติ "ไอมากกว่า 2 สัปดาห์" ทุกรายเพื่อส่งตรวจถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR)	-กลุ่มงานการแพทย์ -กลุ่มงานการพยาบาล	
2.เร่งรัดการนำระบบ AI มาช่วยในการคัดกรองวัณโรคโดยการอ่านภาพรังสีทรวงอก (X-ray) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	-กลุ่มงานรังสีวิทยา	ย.เข้าอบรมทำฝึกเพิ่ม 15-21 มี.ค 69
3.กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด(House hold contact/Closed Contact) ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน (ปี2567,2568 และ2569) โดยใช้รูปแบบการค้นหาเชิงรุกหรือรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ80 ภายใน 31 มีนาคม 2569	-PCU	100% (ผู้สัมผัสจริง) เป้า KPI คือ 1/3 คน แต่ Pt เรามีคนอยู่ร่วมบ้านเพียง 1 คน ทำให้ไม่ได้ตามเป้าที่ สสจ. ตั้งไว้
4.กลุ่มผู้ติดสารเสพติด/ดิดสุราเรื้อรัง ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดยาเสพติดทุกราย ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 60 ภายใน 31 มีนาคม 2569	-กลุ่มงานการพยาบาล -กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	
5.กลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันลดลง 5.1 กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (ระยะที่4,5) ที่มารับบริการในคลินิกโรคไต ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 60 ภายใน 31 มีนาคม 2569 5.2 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน HbA1C > 7 mg% ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 50 ภายใน 31 มีนาคม 2569	-กลุ่มงานการพยาบาล -PCU	-วันพุธคลินิกCKD -ทุกวันจันทร์DM
6.กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีโรคร่วม 6.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปี COPD ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ60 ภายใน 31 มีนาคม 2569 6.2 กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปี DM ที่มารับบริการในคลินิกให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ80) ภายใน 31 มีนาคม 2569	-กลุ่มงานการพยาบาล -PCU	-วันศุกร์คลินิกCOPD -ทุกวันจันทร์DM

ข้อสังการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7.กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ภายใน 31 มีนาคม 2569	-PCU	วันศุกร์คลินิกเติมภูมิ
8.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ100 ภายใน 31 มีนาคม 2569	-PCU	ตรวจสุขภาพประจำปี
9.กลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ100 กลุ่มผู้ต้องขังรายเก่า ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 60 กลุ่มผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ35 ภายใน 1 มีนาคม 2569 (รพ.แม่ข่าย)	-ไม่มี	
10.กำกับตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในระบบ NTIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	-PCU	
11.พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาตาม ช่องทางที่กำหนด	-PCU	
12.นำเสนอผลการดำเนินงานและนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ในคณะกรรมการ Service Plan สาขาวัณโรคระดับจังหวัด ทุก 2 สัปดาห์	-กลุ่มงานการแพทย์ -กลุ่มงานการพยาบาล	

หมายเหตุ

- ให้ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล วันที่มารับบริการ HN ชื่อ-สกุล กลุ่มเสี่ยง(เป้าหมายข้างต้น)

ตามคิวอาร์โค้ด/link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gxeq8J6ELgFZQlWhL4IMuyZeCbXJzk9u6lDj65RQ2HI/edit?usp=sharing

- หาก X- ray เลยโดยไม่เอาขอดเคลม ทำได้เลย แต่จะไม่ได้เงินชดเชย

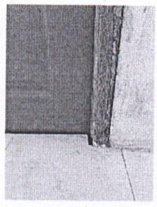
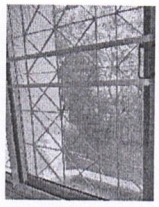
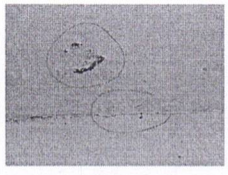
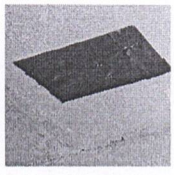
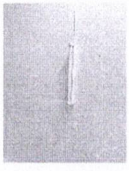
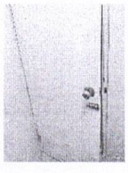
ผลการดำเนินงาน

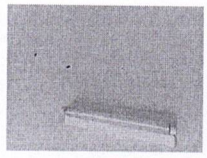
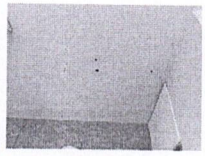
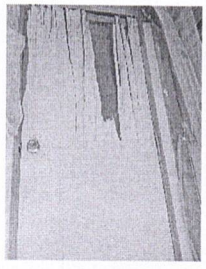
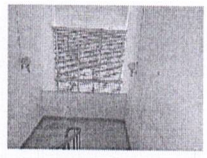
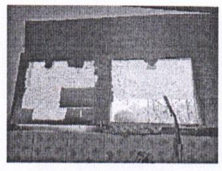
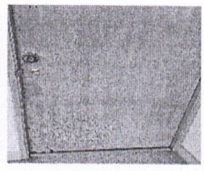
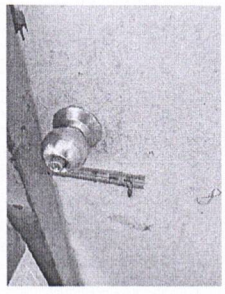
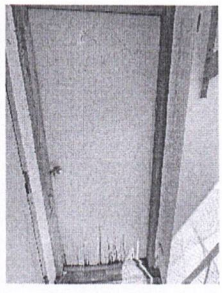
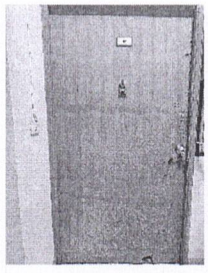
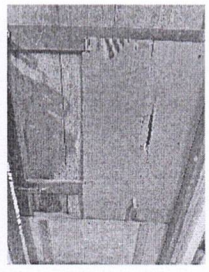
กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 4,5) = 90	16	17
ผู้ป่วยเบาหวาน HbA1C > 7 mg% = รอOPDดึงข้อมูล	147	NA
ผู้สูงอายุ 65 ปี COPD = 200	20	10
ผู้สูงอายุ 65 ปี DM = รอOPDดึงข้อมูล	73	NA
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี = 100	32	32
บุคลากรทางการแพทย์ = 172	150	87
รวม	444	NA

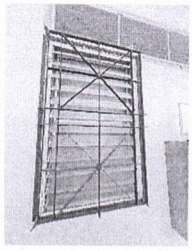
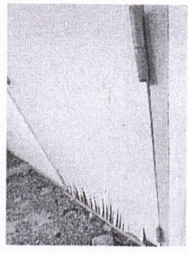
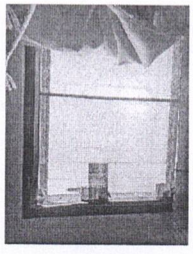
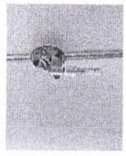
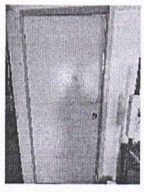
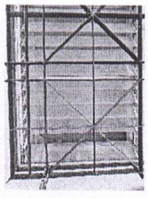
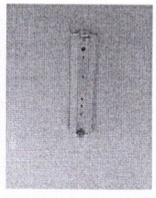
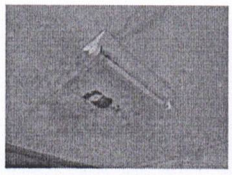
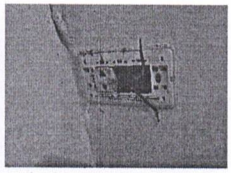
หมายเหตุ เฉลี่ยโดยประมาณ 20-30 Case/สัปดาห์ (เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม เนื่องจากครบรอบ 1 ปีในการเคลมNTIP 100/Case)

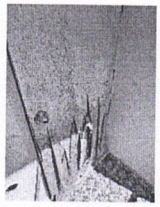
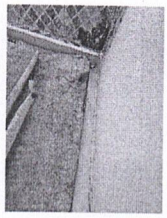
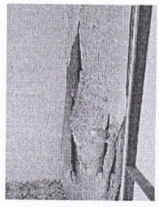
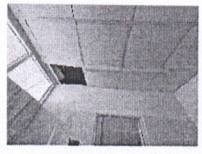
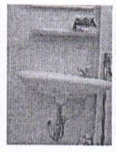
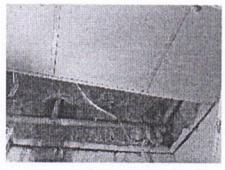
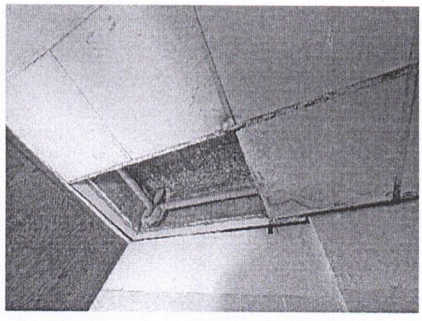
เลขที่รับหมายเลข 5

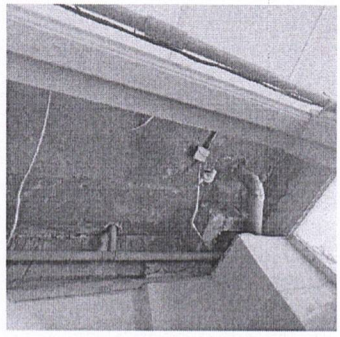
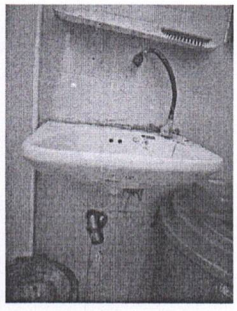
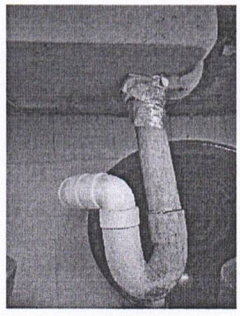
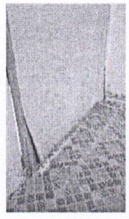
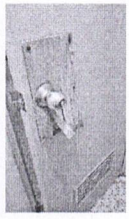
แบบสำรวจรายการซ่อม บ้านพักโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี

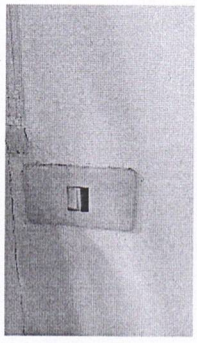
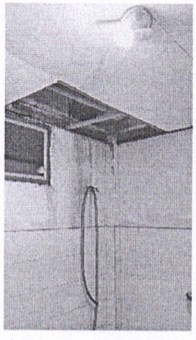
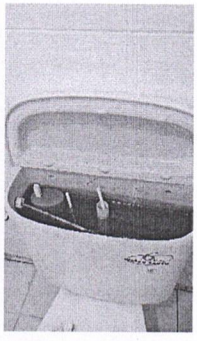
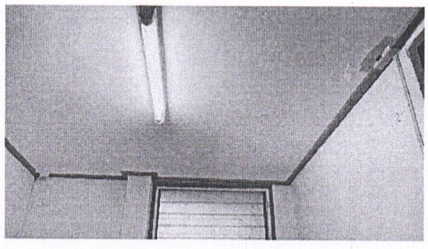
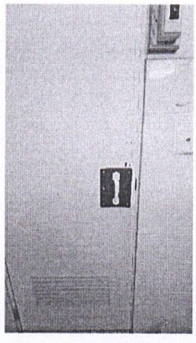
แฟลตแพทย์			
ห้อง	**ชื่อ - สกุล**	**รายการซ่อม**	**รูปภาพ**
334	น.ส.ปรางปริยา โตราณุรักษ์สกุล	1. ก๊อกน้ำใต้ซิงค์ล้างจานมีซ้ำซึม 2. ไฟติดผนังไม่ติด 3-4หลอด (ซื้อหลอดมาเองแล้ว เปิดที่ครอบหลอดไฟไม่ได้ เลยยังไม่ได้เปลี่ยน) 3. วงกบประตูระเบียงหลังห้องผุ มีรูที่ขอบๆประตู 4. มุ้งลวดขาด หน้าต่างติด เปิดไม่ได้	 
313	นายปัฐวี วังคีรี	1. ประตูระเบียง 2. ก๊อกน้ำซิงค์ล้างจาน 3. มุ้งลวดประตู 4. ท่อน้ำรั่ว (ระเบียง) 5. เพดานห้องน้ำ 6. บานเกร็ดห้องนอน ปิดไม่สนิท 7. ไฟภายในห้อง 3 หลอด	
334	น.ส.เบญญา มารุตเสถียร	1. หลังคา + ฝ้าเพดานรั่ว 2. ฝารองนั่งชักโครกกรอบ	 
324	น.ส.รัตนมุขย์ วิโรจน์	1. ฝ้าห้องน้ำพัง 2.ชักโครกชำรุด 2. อ่างล้างมือชำรุด 3. ไฟห้องโถงไม่ติด(ซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนแล้ว ไม่ติดค่ะ) 4. ประตูห้องน้ำ+ลูกบิดชำรุด (ซื้อลูกบิดมาแล้วค่ะ)	 

แฟลตครอบครัว			
ห้อง	ชื่อ - สกุล	รายการซ่อม	รูปภาพ
133	น.ส.วาสนา โตไธสง	1. ฝ้า เพดาน 2. ประตู 3. ไฟทางเดิน	   
111	น.ส.ธัญญษภรณ์ พชสิทธิ์	1. ประตู 2. หน้าต่างห้องน้ำ	 
121	น.ส.ปริยานุช พาหะซา	1. ลูกบิด 2. ประตูหลังห้อง 3. หลอดไฟ	 
112	นางไพรินทร์ พุทธลา	1. ประตูห้าห้อง 2. ประตูหลังห้อง	 

แฟลตครอบครัว (ต่อ)			
ห้อง	ชื่อ - สกุล	รายการซ่อม	รูปภาพ
133	น.ส.ภัฐษณา โพยนอก	1. บานเกล็ดหมุนปิดไม่ได้ 2. ประตูหลังห้องแตก 3. มุ้งลวดขาด	  
124	นางสุพพัตธิดา เถาว์ชาลี	1. หลอดไฟหน้าในห้องน้ำเปิดไม่ติด	
134	น.ส.เจนจิรา พลอยนิล	1. ประตูห้อง 2. บานเกล็ดหน้าต่าง 3. ไฟเพดานห้องครัว 4. ไฟเพดานหน้าห้อง	  
132	น.ส.วิไล แว่นไธสง	1. หลอดไฟกลางห้องโถงไม่ติด + ฝ้ามีน้ำซึม 2. ปลั๊กเต้าเสียบชำรุด	 

แฟลตโสด			
เลขห้อง	**ชื่อ - สกุล**	**รายการซ่อม**	**รูปภาพ**
221	น.ส.ปรียานุช มังสุลุย	1. ประตู	 
234	นายศิว์วิศว์ ศรีมรรควัฒน์	1. ประตู 2. ฝ้าเพดาน	
233	น.ส.พิชญธิดา ปลื้มพันธุ์	1. หลอดไฟ 2. ฝ้า เพดาน 3. อ่างล้างหน้า	 
222	น.ส.สุภาวดี แดริรัมย์	1. ฝ้าในห้องน้ำ	
213	นายอิสระ เข็มพุธทรา	1. .ฝ้าเพดานในห้องน้ำชำรุด 2. ไฟในห้องน้ำ 3. อ่างล้างหน้า 4. น้ำไหลซึมตรงฝักบัว 5. ชักโครกชำรุด 6. ฝ้าห้องน้ำ	

แฟลตโสด (ต่อ)			
เลขห้อง	**ชื่อ - สกุล**	**รายการซ่อม**	**รูปภาพ**
223	นางกัลยาณี มีภักดี	1. ประตูหลังห้อง 2. ฝ้าเพดานห้องน้ำไม่มี 3. ท่อน้ำทิ้งซักโครกห้องข้างบนรั่วน้ำหยดลงมา 4. ไฟหน้าห้องน้ำไม่ติด	
212	น.ส.กฤษณา จำปาโพธิ์	1. ฝ้าเพดานหน้าห้องน้ำชำรุด 2. ไฟฟ้าห้องโถงหน้าห้องน้ำ เบกเกอร์ตัดบ่อยมากเปิดใช้นานไม่ได้ 3. ท่อต่ออ่างล้างหน้าในห้องน้ำชำรุด 4. อ่างล้างจานร้าวท่อน้ำทิ้งชำรุด	 
231	นางฐานิชชา สมพงษ์พันธ์	1. ประตูกลอนห้องน้ำ 2. ประตูห้องนอนด้านหลังห้อง	 

บ้านพัก (บ้าน 2 ชั้น)			
หลัง	ชื่อ - สกุล	รายการซ่อม	รูปภาพ
3	นางศิรินทิพย์ โกนสันเทียะ	1. สวิตช์ไฟข้างบันไดหลุด 2. ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างมือชำรุด (ห้องน้ำชั้นล่าง) 3. เพดานห้องน้ำ (ชั้นล่าง) เปิด 4. เพดานห้องครัวชำรุด มีกลิ่นเหม็นใต้หลังคา 5. ระบบชักโครกชำรุดสายหลุดบ่อย (ห้องน้ำชั้นบน) 6. ประตูไม่มีกลอน 7. กลอนประตูบ้านหน้าหลังปิดยาก 8. ลูกบิดประตูชำรุด	    

เลขสารบาย ๖

ที่ นม ๐๐๓๓.๐๐๑/ว ๕๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
๒๕๕ ม.๑๑ ต.โคกกรวด นม ๓๐๒๘๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ตามข้อเสนอของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอให้หน่วยงานดำเนินการเบิก-ค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการและประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐-๔ ต่อ ๔๕๔
โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-nma@moph.go.th
ชื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา
555th Anniversary of Nakhon Ratchasima
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด-นครราชสีมา ว่ามีความประสงค์ขอปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้สอดคล้องกับสภาพภาระงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๑) แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ ๒๖) ประกาศ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒ ให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น โดยให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าตอบแทนว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ ๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ ๒ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) บุคคลตามข้อ ๑ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้ จะต้องได้รับคำสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยบริการหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยบริการมอบหมาย ให้ไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(๒) การปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ให้หน่วยบริการแต่ละแห่งทบทวนถึงประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการจ่ายค่าตอบแทนโดยรวมทุกปีงบประมาณ แล้วรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมาทราบทุกปีนับแต่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

(๓) กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้เพราะเหตุกระทบต่อสถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการจนอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยบริการนั้นรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมาทราบเพื่อพิจารณา

/ข้อ ๔...

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๖

อ้างถึง	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖	ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฯ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๖
หมวด ๑ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อ ๕ ให้แพทย์ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราต่อไปนี้		
๑) กรณีที่ปฏิบัติงานประจำอาคารผู้ป่วยนอก จะต้องพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลาและทันท่วงทีเมื่อมีผู้ป่วยมารับบริการ	๑,๒๐๐ บาท	๑,๓๒๐ บาท (เฉพาะแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ๒,๔๐๐ บาท
๒) กรณีที่ปฏิบัติงานแพทย์เวรในประจำหน่วยบริการหรือรอให้คำปรึกษา	ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน ตามบัญชีหมายเลข ๑ ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ บาท	ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน ตามบัญชีหมายเลข ๑ ไม่ต่ำกว่า ๖๖๐ บาท
๓) กรณีที่ปฏิบัติงานให้บริการต่างหน่วยบริการ	ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน ตามบัญชีหมายเลข ๑ ไม่ต่ำกว่า ชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท	ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน ตามบัญชีหมายเลข ๑ ไม่ต่ำกว่า ชั่วโมงละ ๑๔๐ บาท
ข้อ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรหรือผลัด มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในอัตราดังต่อไปนี้		
๑) ทันตแพทย์	๑,๒๐๐	๑,๓๒๐
๒) เภสัชกร	๗๘๐	๘๖๐
๓) นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข	๖๕๐	๗๒๐
๔) พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค	๕๒๐	๕๘๐
๕) ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค	๓๙๐	๔๓๐
๖) เจ้าหน้าที่อื่น เช่น เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน		

อ้างถึง	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖	ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฯ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๖
เป็นต้น ให้ได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน โดยให้เบิกตามวุฒิการศึกษาที่เริ่มต้นของสายงานในตำแหน่งที่เบิกค่าตอบแทน		
สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า	๓๙๐	๔๓๐
สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า	๕๒๐	๕๘๐
สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	๖๕๐	๗๒๐
๗) ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ	๓๓๐	๓๖๐
ข้อ ๗ ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ	ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน ตามบัญชีหมายเลข ๒ ไม่ต่ำกว่า ชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท	ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน ตามบัญชีหมายเลข ๒ ไม่ต่ำกว่า ชั่วโมงละ ๑๔๐ บาท
ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทีมผ่าตัด มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ดังต่อไปนี้		
๑) การบริการในหน่วยบริการ หรือนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในทีม-ช่วยผ่าตัด ให้ได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนผู้ป่วยแต่ละราย	อัตราคนละ ๑๒๐ บาท สำหรับการผ่าตัดเล็ก อัตราคนละ ๒๔๐ บาท สำหรับการผ่าตัดใหญ่	อัตราคนละ ๑๔๐ บาท สำหรับการผ่าตัดเล็ก อัตราคนละ ๒๙๐ บาท สำหรับการผ่าตัดใหญ่
๒) การบริการนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ พยาบาลที่เตรียมผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดแต่ละราย	ทีมละ ๑๒๐ บาท สำหรับทีมผ่าตัดเล็ก และ ทีมละ ๓๖๐ บาท สำหรับทีมผ่าตัดใหญ่	ทีมละ ๑๔๐ บาท สำหรับทีมผ่าตัดเล็ก และ ทีมละ ๔๓๐ บาท สำหรับทีมผ่าตัดใหญ่
๓) อัตราค่าตอบแทนตาม (๑) หรือ (๒)	รวมกันแล้วเงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่ำสุดของแต่ละคนจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดตาม ข้อ ๖	รวมกันแล้วเงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่ำสุดของแต่ละคนจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดตาม ข้อ ๖
ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ ที่ให้บริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ดังต่อไปนี้		
๑) ทันตแพทย์	๑๒๐ บาท/ชั่วโมง	๑๔๐ บาท/ชั่วโมง
๒) เภสัชกร	๙๐ บาท/ชั่วโมง	๑๑๐บาท/ชั่วโมง

อ้างถึง	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖	ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฯ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๖
๓) นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข	๘๐ บาท/ชั่วโมง	๑๐๐บาท/ชั่วโมง
๔) พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค	๖๐ บาท/ชั่วโมง	๗๐ บาท/ชั่วโมง
๕) ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค	๕๐ บาท/ชั่วโมง	๖๐ บาท/ชั่วโมง
ข้อ ๑๐ กรณีที่หน่วยบริการ มีความจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะเวรรอ (on call) เพื่อให้บริการผู้ป่วย ให้คณะกรรมกาบริหารหน่วยบริการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เทียบเคียงในข้อ ๖		
หมวด ๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ดังต่อไปนี้		
๑) เภสัชกร	๙๐ บาท/ชั่วโมง	๑๑๐ บาท/ชั่วโมง
๒) นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข	๘๐ บาท/ชั่วโมง	๑๐๐ บาท/ชั่วโมง
๓) พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค	๖๐ บาท/ชั่วโมง	๗๐ บาท/ชั่วโมง
๔) ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค	๕๐ บาท/ชั่วโมง	๖๐ บาท/ชั่วโมง
๕) เจ้าหน้าที่อื่น ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการ ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง	ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด ตามหมวด ๑	ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด ตามหมวด ๑
หมวด ๓ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายและหรือเวรผลัดดึกของเจ้าหน้าที่ ข้อ ๑๖		
๑) พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)	๓๖๐	๓๖๐

อ้างถึง	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖	ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฯ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๖
๒) พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) พนักงานกู้ชีพที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-I ๒ ปี)	๒๗๐	๒๗๐
๓) ผู้ช่วยพยาบาล	๒๕๕	๒๕๕
๔) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือพยาบาล พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B ๑๑๐ ชั่วโมง	๑๒๐	๑๒๐
หมวด ๕ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ		
ข้อ ๒๔ ให้แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษซึ่งได้รับการประกาศ	๕,๐๐๐ บาท/เดือน	๕,๐๐๐ บาท/เดือน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ หากรายละเอียดใดไม่ปรากฏในมติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว

๒. อนุมัติปรับค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๑, ๒ รายการหัตถการ ร้อยละ ๒๐ ทุกรายการ เศษหลักหน่วย ตั้งแต่ ๕ ปัดขึ้น น้อยกว่า ๕ ปัดเศษ ๐